



INSTITUTT FOR INDUSTRIELL DESIGN

TPD4166 - DESIGN 8 - STRATEGI

Hjemmesykehus - St.Olavs Hospital

Forfattere:

Brage Busetth Hammerstad

Kaisa Almquist

Karoline Zhiwen Lie Holm

Oskar Rise

May 2026

Anerkjennelse

Vi vil rette en særlig takk til vår veileder Kristine Holbø fra Tjenesteinnovasjonssenteret (TIPS) ved St. Olavs Hospital for et godt samarbeid, konstruktive tilbakemeldinger og for å inkludere oss i arbeidet med hjemmesykehus. Takk også til seksjonsleder Jarl Reitan for å legge til rette for prosjektet.

En spesiell takk til TIPS for muligheten til å delta på Landskonferansen for hjemmesykehus i Kristiansund, som ga oss verdifull innsikt og et bredere perspektiv på feltet.

Takk til vår veileder André Liem ved Institutt for design, NTNU, for mange gode veiledningsmøter og konstruktive innspill.

Til slutt takker vi alle informantene som har delt sine erfaringer med oss.

Trondheim, mai 2026



Innholdsfortegnelse

Anerkjennelse	i
Figuroversikt	v
Forkortelser og begrepsforklaringer	vi
Sammendrag	vii
Summary	viii
1 Introduksjon	1
2 Bakgrunn	2
2.1 Dagens praksis for hjemmesykehus	2
2.1.1 Hjemmesykehus i Trondheim	2
2.2 Kultur	3
2.3 Geografiske hensyn	3
2.4 Samhandlingsstruktur	3
2.5 Oppsummering	3
3 Innsikter	5
3.1 Datainnsamling	5
3.1.1 Intervjuer og faglige samtaler	5
3.1.2 Tilgang til informanter	6
3.2 Finansierungsordning som barriere	7
3.2.1 Motstridende finansierungsmodeller	7
3.2.2 Ressursfordeling	7
3.2.3 Behov for standardisert fordeling	8
3.3 Kvalitet og effektivitet	8
3.4 Teknologi	8
3.5 Samarbeid mellom sykehus og kommune	9
3.6 Pårørende	9
3.7 Oppsummering	10
4 Utarbeidelse av mulighetsrom	11
4.1 Utforskningsområder	11
4.2 Fordypning og idegenerering	13

4.3	Første strategiske retning: Innleggelse som utgangspunkt	13
4.4	Vendepunkt: Landskonferansen for hjemmesykehus	14
4.4.1	PESTEL-analyse	14
4.4.2	SWOT-analyse	16
4.5	Mulighetsrom	16
4.5.1	Strategisk mulighet 1: Innleggelse som utgangspunkt	16
4.5.2	Strategisk mulighet 2: Utvidet hjemmesykehus	17
4.6	Avgjørende veivalg	17
5	Strategisk retning	18
5.1	Kjerneprinsipper	18
5.2	Prioriterte pasientgrupper	18
5.3	Hjemmesykehus i fremtiden	19
6	Tjenestekonsept	23
6.1	Geografisk tilpasset tjeneste	25
6.2	Tjenestekomponenter	25
6.2.1	Hjemmesykehus-sentralen	25
6.2.2	Helsevakt	26
6.2.3	Trygg overgang	26
6.2.4	Skjemabasert vurdering	27
6.2.5	Teknologistøttet hjemmebehandling	27
6.3	Tjenesten som helhet	28
7	Refleksjoner	30
7.1	Hjemmesykehus som trend	30
7.1.1	Hvorfor trendbygging er viktig	30
7.1.2	St.Olavs bidrag til trendbygging	30
7.2	Flaskehalser	31
7.2.1	Overbelastning av hjemmesykepleien	31
7.2.2	Belastning på pårørende	32
7.2.3	Fragmentert teknologi	32
7.3	Potensielle gevinster og begrensninger	32
7.3.1	Hva strategien kan oppnå	32
7.3.2	Hva strategien ikke løser alene	33
8	Konklusjon	34

Referanser	35
Vedlegg	38
A Intervju 1: Avansert hjemmesykehus (AHS)	38
B Intervju 2: OUS Hjemme	40
C Intervju 3: Hjemmesykehus i Kristiansund	42
D Intervju 4: Kreftklinikken, St. Olavs hospital	44
E Intervju 5: Trondheim kommune – e-helse og organisatoriske perspektiver	45
F Intervju 6: Mammografibussen	48
G Intervju 7: Hjemmesykepleien	49
H Skriftlig kommunikasjon: Ambulansetjenesten	50

Figuroversikt

1	Illustrert prosess fra innsikt til strategisk retning	11
2	Fra fellesnevnerne til utforskningsområder	12
3	Fase 1: Hjemmesykehus i distriktet	13
4	Fase 2: Hjemmesykehus introduseres i Trondheim	14
5	PESTEL-analyse	15
6	SWOT-analyse	16
7	Implementeringsforløp for hjemmesykehus	20
8	Brukerreise: Tjenesten fra pasienten sitt perspektiv	23
9	Flowchart som viser beslutningspunkter i tjenesten	24
10	Visualisering av bemanning på hjemmesykehussenrtalen	26
11	Aktørkart	28
12	Service blueprint illustrerer tjenesten	29
13	Post-it-lapper fra intervju med AHS	39
14	Rangeringsøvelse	47

Forkortelser og begrepsforklaringer

Forkortelser

AHS	Avansert hjemmesykehus
CVK	Sentralt venekateter
HS	Hjemmesykehus
ISF	Innsatsstyrt finansiering
IV	Intravenøs
KOLS	Kronisk obstruktiv lungesykdom
OUS	Oslo universitetssykehus
PESTEL	Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal
RS-tilskuddet	Rekrutterings- og samhandlingstilskuddet
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Begrepsforklaringer

Delte stillinger

Stillinger der helsepersonell arbeider både på sykehusavdeling og i hjemmesykepleie eller hjemmesykehus, for å opprettholde fagkompetanse begge steder.

Helsevakt

Utvidelse av prehospital tjeneste i distriktkommunene, der ambulansepersonell utfører både akutte utrykninger og planlagte hjemmebesøk.

Hjemmesykehus

Organisert spesialisthelsetjeneste som leveres i pasientens hjem fremfor på sykehuset.

Hjemmesykehussentraten

Dedikert team ved St. Olavs Hospital med koordineringsansvar for hjemmebasert behandling.

HPH 0-skjema

Kartleggingsverktøy utviklet av Samnanger kommune for strukturert vurdering av pasientens egnethet for hjemmebehandling.

Innlagt hjemme

Pasient som er formelt innlagt ved sykehuset, men oppholder seg hjemme og mottar behandling der.

Tidlig utskrivelse

Tidlig utskrivelse fra sykehus med oppfølging i hjemmet.

Trygg overgang

Strukturert overgangsordning som sikrer trygg oppstart og avslutning av hjemmebehandling, inkludert 72 timers åpen telefon etter utskrivelse.

Unngå innleggelse

Strategi for å unngå unødvendige innleggelser ved å tilby korttidsbehandling i hjemmet.

Utforskningsområder

Avgrenset søkeområder som representerer strategiske spørsmål eller systemiske utfordringer identifisert i analysefasen.

Sammendrag

Norsk helsetjeneste står overfor betydelige kapasitetsutfordringer forsterket av en aldrende befolkning. Denne rapporten utforsker hvordan St. Olavs Hospital kan utvikle et strategisk forankret hjemmesykehuskonsept som både avlaster sykehuset og styrker behandlingskvaliteten for pasienter i hele opptaksområdet.

Analysen bygger på intervjuer med aktører i eksisterende hjemmesykehustjenester, deltakelse på Landskonferansen for hjemmesykehus 2026 og kartlegging av strukturelle rammebetingelser. Innsikten viser at hjemmesykehus allerede praktiseres i Norge, men som spredte initiativ uten felles organisatorisk fundament. Fire systemiske barrierer begrenser utviklingen: uklare finansierungsordninger mellom forvaltningsnivåene, fragmentert teknologisk infrastruktur, manglende samhandlingsstrukturer mellom sykehus og kommune, samt risiko for økt belastning på både kommunal hjemmesykepleie og pårørende.

Den anbefalte strategien kombinerer to tilnærminger under ett integrert system, ved å unngå innleggelse gjennom styrket førstelinjediagnostikk, og tidlig utskrivelse med strukturert oppfølging i hjemmet. Kjernen er en hjemmesykehussentral ved St. Olavs med koordineringsansvar gjennom hele pasientforløpet, støttet av geografisk tilpassede løsninger. I Trondheim ivaretar sykehuset selv fysisk oppfølging, mens distriktkommunene får etablert lokale helsevakter som fungerer som sykehusets forlengelse i felt, med digital tilgang til spesialistkompetanse. Sentrale komponenter inkluderer skjemabasert egnethetsvurdering, delte stillinger mellom sykehus og kommune for kompetanseoverføring, og en trygg overgangsordning med 72 timers åpen telefon etter utskrivelse.

Implementeringen er planlagt som en sjufaset prosess over ti til femten år, fra etablering av grunnstrukturer og parallelle piloter til nasjonal standardisering. Strategien kan redusere unødvendige innleggelser og gi bedre pasientopplevelse, men løser ikke kapasitetsutfordringen alene. Full effekt forutsetter endringer i nasjonale rammebetingelser og kulturell omstilling i organisasjonen. St. Olavs har mulighet til å være en aktiv pådriver for hjemmesykehus på nasjonalt nivå gjennom dokumentasjon, erfaringsdeling og dialog med beslutningstakere.

Summary

Norwegian healthcare faces significant capacity challenges intensified by an aging population. This report explores how St. Olavs Hospital can develop a strategically grounded hospital at home concept that both relieves hospital pressure and enhances treatment quality for patients across the entire catchment area.

The analysis draws on interviews with stakeholders in existing hospital at home services, participation in the 2026 National Hospital at Home Conference, and mapping of structural framework conditions. Insights reveal that hospital at home is already practiced in Norway, but as scattered initiatives without shared organizational foundation. Four systemic barriers constrain development: unclear financing arrangements between governance levels, fragmented technological infrastructure, lacking collaboration structures between hospitals and municipalities, and risk of increased burden on both municipal home care services and family caregivers.

The recommended strategy combines two approaches within one integrated system: admission avoidance through strengthened frontline diagnostics, and early discharge with structured home based follow up. The core is a hospital at home coordination center at St. Olavs with responsibility throughout the entire patient pathway, supported by geographically adapted solutions. In Trondheim, the hospital manages physical follow up directly, while district municipalities establish local health response units functioning as the hospital's extension in the field, with digital access to specialist competence. Key components include form based eligibility assessment, split positions between hospital and municipality for competence transfer, and a safe transition arrangement with 72 hour open telephone line after discharge.

Implementation is planned as a seven phase process over ten to fifteen years, from establishing foundational structures and parallel pilots to national standardization. The strategy can reduce unnecessary admissions and improve patient experience, but does not solve the capacity challenge alone. Full impact requires changes in national framework conditions and cultural transformation within the organization. St. Olavs has the opportunity to be an active driver for hospital at home at national level through documentation, experience sharing and dialogue with decision makers.

1 Introduksjon

Hjemmesykehus får stadig økende oppmerksomhet både i Norge og resten av verden. Flere studier viser gode resultater for pasienters velferd, økt behandlingskvalitet, og i noen tilfeller kostnadsbesparelser. På nasjonalt nivå rettes det fokus mot å utforme en mer sammenhengende og bærekraftig helsetjeneste (Vestre 2026). Derfor gjennomfører St. Olavs Hospital en konseptutredning denne våren, i samarbeid med fem kommuner med ulik demografi og avstand til sykehuset. Hensikten er å utforske hvordan hjemmesykehus kan gjennomføres i praksis, med ekstra fokus på innleggelse hjemme, slik at pasienter i Trondheim og på Hitra har det samme tilbudet. Denne rapporten er utarbeidet parallelt med konseptutredningen, men er et selvstendig arbeid med egen metodikk og egne anbefalinger.

Norsk helsetjeneste er allerede presset på kapasitet, og situasjonen vil bli mer kritisk de kommende årene. Andelen eldre vil øke betydelig, med en økning i antallet mennesker med behov for helsehjelp som direkte konsekvens (Barstad and Hammersland 2025). Spørsmålet er derfor ikke bare om hjemmesykehus er mulig, men hvordan hjemmesykehus kan bidra til å avlaste systemet. Risikoen er at det flytter arbeidsbelastningen fra sykehus til hjem uten tilstrekkelig omfordeling av ressurser.

Denne rapporten undersøker hvilke betingelser som må ligge til grunn for at hjemmesykehus både er et kapasitetsbesparende og kvalitetsøkende grep for St. Olavs Hospital, og hva slags utforming det krever. Rapporten er en strategisk analyse etterfulgt av et konseptuelt eksempel på hvordan tjenesten "hjemmesykehus" kan se ut i praksis. Analysen bygger på intervjuer med aktører i og rundt norske hjemmesykehustjenester, deltakelse på Landskonferansen for hjemmesykehus 2026, og dokumentanalyse.

2 Bakgrunn

Dette kapittelet beskriver konteksten hjemmesykehus ved St. Olavs skal utvikles i. Det omfatter demografiske prognoser, eksisterende praksis, kultur, geografi og samhandlingsstruktur mellom sykehus og kommune. Alle disse forholdene setter rammene for hvordan hjemmesykehus kan utvikles ved St. Olavs, men selve konseptet er ikke nytt. Helsedirektoratet (2021a) beskriver flere eksempler på hjemmesykehus i Norden så tidlig som på 90-tallet. De siste årene har interessen for å flytte behandling fra sykehus til hjemmet økt betydelig, både i Norge og internasjonalt.

Både primær- og sekundærhelsetjenesten i Norge er allerede presset på kapasitet. Lange ventekøer og utfordringer tilknyttet bemanning preger helsevesenet (Vestre 2026), og sykepleiere, særlig i hjemmetjenesten, opplever en arbeidsbelastning langt utover det som er bærekraftig (Hestvik 2026). Nesten halvparten er fysisk utmattet etter jobb, og nesten en tredjedel sier de ikke har tid til å gjøre jobben sin skikkelig (Norsk Sykepleierforbund n.d.). Dette gjør rekruttering stadig vanskeligere, og 8 av 10 kommuner opplever det som krevende å få tak i sykepleiere (Helsedirektoratet 2025a).

Behovet for helsepersonell vil fortsette å øke. Regjeringen estimerer et behov for 180 000 flere personer i helse- og omsorgssektoren innen 2060 (Helsedirektoratet 2025a). I 1920 var én prosent av befolkningen over 80 år. I 2020 var andelen fire prosent, og frem mot 2060 er den ventet å tredoble seg til 12 prosent (Strand et al. 2023). Dette innebærer et vedvarende, strukturelt kapasitetsproblem som krever nye måter å organisere helsetjenesten på. På bakgrunn av dette har myndighetene tydelige mål om forbedringer. I nasjonal helse- og samhandlingsplan nevnes digital oppfølging og nye organiseringsformer som aktuelle tiltak (Regjeringen 2024a). Det overordnede målet er en mer sammenhengende og bærekraftig tjeneste som skal bidra til en friskere befolkning (Vestre 2026). Hjemmesykehus har i denne konteksten fått økt oppmerksomhet som et mulig svar på kapasitetsutfordringene. Hvorvidt det faktisk løser dem avhenger imidlertid av hvordan tjenesten utformes.

2.1 Dagens praksis for hjemmesykehus

Hjemmesykehus som praksis i dag, er veldig fragmentert og det er store regionale og lokale forskjeller når det gjelder hvilken grad det er utviklet og implementert. Det finnes ingen tydelige nasjonale standarder for hjemmesykehus, og hva definisjonen rommer er uklart. Organiseringen og behandling i de ulike hjemmesykehusene er varierende, og kan omfatte alt fra innleggelse hjemme, til digital oppfølging, poliklinisk behandling, og ambulante tjenester som utføres i hjemmet. På bakgrunn av at hjemmesykehus ikke er systematisert, har utviklingen i Norge i stor grad vært drevet av ildsjeler og engasjerte ledelser, se vedlegg A og C.

Et eksempel på eksisterende hjemmesykehus i Norge er OUS Hjemme, som driver både hjemmesykehus for barn, digital oppfølging og stamcelletransplantasjon, se vedlegg B. I Kristiansund gir de intravenøs behandling hjemme gjennom en IV-pumpe til pasienter som normalt sett ville vært innlagt på sykehus, se vedlegg C, og ved St.Olavs har de et omreisende team som driver avansert hjemmesykehus for barn, se vedlegg A. Felles for alle disse er at tilbudet er begrenset til pasienter innenfor én times kjøring fra sykehuset. Det er et tydelig skille mellom hva som tilbys pasienter nær sykehuset og de som har lengre reisevei. For pasienter lenger unna krever hjemmebehandling samarbeid med kommunale helsetjenester, slik det blant annet gjøres på Island gjennom egne lokale enheter (Guðnadóttir 2026). En annen fellesnevner er at sårbare grupper som barn og skrøpelige eldre har hatt størst fokus i utviklingen av hjemmesykehus til nå, se vedlegg A, (Elkjær 2026).

2.1.1 Hjemmesykehus i Trondheim

St.Olavs i Trondheim har allerede et fungerende hjemmesykehustilbud. Avansert Hjemmesykehus for barn (AHS) gir behandling til barn opp til 18 år som bor innenfor én times reisevei fra St. Olavs. AHS oppsøker dem hjemme, på skole eller i barnehage. De gjennomfører et bredt spekter av behandlinger fra blodprøvetaking til kreftbehandling og palliasjon. Teamet består av åtte sykepleiere og én barnelege, og tilbyr nå behandling hele døgnet, syv dager i uka. Dette gjør at

avdelingen som tidligere kun har hatt polikliniske pasienter, også kan ta inn barn som kan være innlagt i eget hjem.

For voksne finnes det foreløpig ikke et tilsvarende tilbud, men enkelte avdelinger gjennomfører deler av behandlingen utenfor sykehuset. Kreftklinikken følger opp enkelte pasienter med behandling eller palliasjon i hjemmet, se vedlegg D. Dette er ressurskrevende slik det gjøres i dag, men øker pasienttilfredsheten og sparer syke pasienter for unødvendige reiser.

2.2 Kultur

St.Olavs er organisert i en tydelig hierarkisk struktur, der avdelinger i stor grad opererer selvstendig. Dette gir klare, faglige ansvarslinjer og roller i arbeidshverdagen, men gjør samtidig omstilling og samarbeid på tvers av avdelinger krevende. For at endring skal få gjennomslag må den forankres både i ledelsen og blant de som skal bruke løsningene i praksis. Kommer den kun nedenfra, vil den kunne stopper i mangel på formell støtte og ressurser (Rohde et al. 2015).

Sykehuset opplever som nevnt over, store utfordringer med kapasitet. Dette kan være et direkte hinder for innføring av nye arbeidsmetoder. Omstilling og nye tiltak kan i overgangsperioder krever ekstra tid, ressurser og opplæring, som kan oppfattes som en vanskelig prioritering på i en ellers hektisk arbeidshverdag, se vedlegg D. Kulturen er ikke nødvendigvis mot endring, men endring krever både tydelig forankring på flere nivåer, og gode strategier for gjennomføring av endringene.

2.3 Geografiske hensyn

Som regjeringen påpeker, er det en reell utfordring at ikke alle i Norge har tilgang på samme behandling (Regjeringen 2024a). Norge er et land med store geografiske avstander, som gjør det vanskelig å tilby tilsvarende behandling i Nord-Norge som i Trondheim. Ansvarsområdet til St.Olavs spenner fra bynære kommuner til distrikter med lange avstander både internt og til nærmeste sykehus. Ett eksempel på en distriktskommune er Hitra, med omtrent 5500 innbyggere der avstanden fra kommunesentrum til ytterpunkt på øya er ca 50 minutter, og avstand fra kommunesentrum til nærmeste sykehus er omtrent en time (Wahl and Holbø 2026). St.Olavs har derfor besluttet at en satsning på hjemmesykehus i større skala skal utarbeides slik at alle kommuner som ønsker å tilby hjemmesykehus til sine innbyggere, kan få det. Det vil si at både innbyggere i Trondheim kommune og Hitra kommune skal ha muligheten til å være på hjemmesykehus.

2.4 Samhandlingsstruktur

Kommunikasjon og samhandling mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten er i dag fragmentert. Aktørene opererer i stor grad selvstendig, med begrensede strukturer for løpende informasjonsutveksling. I distriktskommuner der avstandene til nærmeste sykehus er store, har mange kommuner utviklet praksis som i realiteten overlapper med det hjemmesykehus innebærer, uten at dette er formalisert som spesialisthelsetjeneste (Personlig kommunikasjon, hjemmesykepleier fra Aukra, 22.april 2026). Denne praksisen foregår imidlertid uten den faglige støtten og finansieringen som følger med et sykehusansvar. Det illustrerer at grensen mellom primær- og sekundærhelsetjeneste i praksis allerede er uklar og at hjemmesykehus i noen kommuner ikke er noe nytt.

2.5 Oppsummering

Kapittelet viser at hjemmesykehus allerede skjer mange steder, men det er i liten skala og er ikke koordinert. Kommuner løser oppgaver som kunne vært assistert av spesialisthelsetjeneste, avdelinger følger opp pasienter hjemme uten felles struktur, og enkeltstående initiativer for hjemmesykehus jobber isolert fra hverandre. Samtidig har St.Olavs og de tilhørende kommunene en geografi som setter ulike rammer for hva som er mulig å tilby. Spørsmålet videre er derfor ikke

om hjemmesykehus skal innføres, men hvordan det kan organiseres slik at det som allerede skjer uformelt blir forsvarlig, finansiert og skalerbart.

3 Innsikter

Dette kapitlet presenterer innsikten som danner grunnlaget for prosjektets videre arbeid. Kapitlet er strukturert rundt de temaene som gikk igjen på tvers av datakilder: finansieringsordninger, forholdet mellom kvalitet og effektivitet, teknologi, samarbeid mellom sykehus og kommune, og pårørendes rolle. Avslutningsvis oppsummeres innsikten i en problemstilling som styrer det videre designarbeidet.

3.1 Datainnsamling

Datainnsamlingen består av en kombinasjon av direkte kommunikasjon og deltakelse på Hjemmesykehus Landskonferansen 2026 i Kristiansund. Innsikten ble innhentet fra personer i tjenesteinnovasjonssentret, prehospital tjeneste, kliniske avdelinger, kommunal e-helse, fastlegetjeneste og etablerte hjemmesykehusprogrammer. Konferansen ga i tillegg bred innsikt på tvers av roller og regioner, og belyste feltet fra nye perspektiver.

3.1.1 Intervjuer og faglige samtaler

Informantene ble valgt for å sikre innsikt fra alle relevante ledd i en hjemmesykehuskjede, fra etablerte hjemmesykehusprogrammer og kliniske avdelinger til kommunal hjemmetjeneste og prehospital tjeneste. Det var særlig viktig å komme i kontakt med personer som allerede driver fungerende hjemmesykehusløsninger, for å forstå hva som fungerer og hva som begrenser dem.

Datainnsamlingen består av en kombinasjon av semistrukturerte intervjuer, møter og skriftlige henvendelser. Intervjuene tok utgangspunkt i forberedte spørsmål, men åpnet for at samtalen kunne følge informantens erfaringer og perspektiver. Møtet med Kreftklinikken var ustrukturert og ble ledet av gruppens veileder fra St. Olavs hospital. Den skriftlige korrespondansen ble gjennomført over meldinger og e-post, og ga innsikt fra fagpersoner det var enklere å henvende seg til på den måten. Fullstendige sammendrag av alle intervjuer og korrespondanser finnes som vedlegg.

	Intervju AHS (Avansert hjemmesykehus)
Informant	Sykepleier og leder, AHS
Dato	9. februar 2026, 09:00–10:00
Format	Digitalt, semistrukturert
Deltakere	3 gruppemedlemmer + 1 informant
	Intervju OUS Hjemme
Informant	Designer og innovasjonsrådgiver, OUS
Dato	9. februar 2026, 13:00–14:00
Format	Digitalt, semistrukturert
Deltakere	3 gruppemedlemmer + 1 informant
	Intervju Kristiansund
Informant	Sykepleier og forsker, Kristiansund kommune
Dato	16. februar 2026, 09:00–10:00
Format	Digitalt, semistrukturert
Deltakere	3 gruppemedlemmer + 1 informant
	Intervju mammografibussen
Informant	Ansatt ved mammografibussen
Dato	1. mars 2026, 16:30–17:00
Format	Telefon, ustrukturert
Deltakere	1 gruppemedlem + 1 informant
	Intervju Trondheim kommune
Informant	Rådgiver innen e-helse, Trondheim kommune
Dato	3. mars 2026, 10:00–11:00
Format	Fysisk, semistrukturert
Deltakere	2 gruppemedlemmer + 1 informant
	Intervju hjemmesykepleien
Informant	Ansatt i hjemmesykepleien
Dato	14. mars 2026, 19:00–20:00
Format	Digitalt, ustrukturert
Deltakere	1 gruppemedlem + 2 informanter
	Intervju Kreftklinikken
Informant	To representanter fra Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Dato	20. mars 2026, 13:00–14:00
Format	Fysisk, ustrukturert
Deltakere	4 gruppemedlemmer + veileder fra St. Olavs + 2 informanter
	Skriftlig kommunikasjon ambulanse
Informanter	To ambulansearbeidere
Dato	Mars 2026
Format	Skriftlig kommunikasjon

Table 1: Oversikt over datainnsamling.

3.1.2 Tilgang til informanter

Som eksterne studenter uten formell tilknytning til St. Olavs ble rekruttering av informanter koordinert gjennom gruppens veileder ved TIPS, Kristine Holbø. Dette sikret at henvendelsene nådde de mest relevante aktørene i riktig kontekst.

3.2 Finansieringsordning som barriere

Finansieringsordningene i dagens helsevesen utgjør en sentral barriere for utvikling av hjemmesykehus. Motstridende økonomiske incentiver mellom sykehus og kommuner, kombinert med mangel på etablerte kompensasjonsordninger, skaper usikkerhet rundt hvem som skal bære kostnadene for hjemmebehandling.

3.2.1 Motstridende finansieringsmodeller

Dagens finansieringsordninger skaper strukturelle utfordringer for samhandling mellom sykehus og kommune. Sykehusene opererer med en kombinasjon av innsatsstyrt finansiering (ISF) og rammetilskudd fra staten. ISF innebærer at sykehusene mottar betaling basert på aktivitet, noe som i praksis gir økonomiske incentiver for innleggelser og polikliniske konsultasjoner (Helsedirektoratet 2025b). Kommunene finansieres derimot gjennom en annen modell. Størsteparten av kommunenes inntekter kommer fra skatteinntekter og rammetilskudd fra staten, såkalte frie inntekter som utgjør om lag 70 prosent av de samlede inntektene. Disse frie inntektene er ikke knyttet til spesifikk behandlingsaktivitet, men skal dekke kommunens lovpålagte oppgaver innenfor blant annet helse og omsorgstjenester (Regjeringen 2023).

Forskjellen i finansieringsmodell gir begrenset grunnlag for samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Ved hjemmebehandling kan sykehuset motta ISF-kompensasjon for pasienten, men fordelingen mellom sykehus og kommune må avtales internt. Kommunen påtar seg dermed økte oppgaver uten forutsigbar økonomisk dekning, noe som skaper usikkerhet om likeverdighet i samarbeidet. Avklaringer rundt dette er dermed en viktig forutsetning for stabile avtaler.

3.2.2 Ressursfordeling

Som et svar på finansieringsutfordringene innførte staten rekrutterings- og samhandlingstilskuddet "RS-tilskuddet" i 2024 (Regjeringen 2024b). Dette statlige tilskuddet skal gjøre det enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om gode pasientforløp. En evaluering av ordningen viser imidlertid at prosjektbaserte tilskudd ikke løser de grunnleggende strukturelle problemene (Moland et al. 2026).

En sentral bekymring er at kommunene risikerer å få betydelig flere arbeidsoppgaver uten økonomisk dekning. Dette gjelder særlig hvis hjemmesykehuspasienter krever spesialisert oppfølging som går ut over kommunens ordinære tjenester. Evalueringen av RS-tilskuddet dokumenterer at mange kommuner opplever samarbeidsrelasjonen med helseforetakene som lite likeverdig. Helseforetakene får ofte for stort gjennomslag i utformingen av prosjekter. Dette fører til oppgaveforskyvning, der kommunene overtar ansvar for tjenester som helseforetakene avvikler uten tilstrekkelig kompensasjon. Særlig små kommuner må vurdere om innsatsen i samarbeidsprosjekter er verdt ressursbruken, og mange mangler kapasitet til å delta (Moland et al. 2026).

Det finnes likevel eksempler som viser at ordningen kan fungerer som en reel katalysator, for eksempel HomeCare+ prosjektet i Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. Prosjektet mottok i mai 2026 et rekrutterings- og samhandlingstilskudd på 11 320 000 kroner fra Helse Nord (Severinsen 2026). Prosjektet skal etablere en kommunedrevet hjemmesykehusmodell der kommunen fungerer som sykehusets operative forlengelse i pasientens hjem, støttet av digitale løsninger og tydelig ansvarsfordeling. Dette viser at tilskuddsordningen kan understøtte konkrete samarbeid, men forutsetter samtidig både kapasitet og vilje fra kommunens side.

Spørsmålet er om slike enkeltprosjekter er tilstrekkelig. Prosjektleder i avdelingen for finansiering i Helsedirektoratet har uttalt at dagens finansieringssystem ikke i seg selv er til hinder for hjemmesykehus (Dahlen 2026), men det eksisterer fortsatt ingen etablert praksis for hvordan kompensasjonen skal fordeles. Tidligere evalueringer av RS-tilskuddet viser at selv når økonomiske virkemidler er på plass, kan resultatet ende i oppgaveforskyvning. Dette understreker behovet for mer permanente og strukturelle løsninger, fremfor prosjektbaserte tilskudd.

3.2.3 Behov for standardisert fordeling

For at hjemmesykehus skal bli økonomisk bærekraftig kreves det tydelige og varige avtaler om ressursoverføring mellom sykehus og kommune. Det må avklares hvor stor andel av ISF-midlene som skal overføres til kommunen, hvilke kostnader som skal dekkes, og hvordan fordelingen skal justeres over tid. Prosjektmidler og godvilje alene er ikke tilstrekkelig. Uten mekanismer som sikrer reell likeverdighet i finansieringen vil kommuner ha liten grunn til å påta seg et større ansvar for spesialisthelsetjenester i hjemmet. Finansieringsordningene er derfor en kritisk barriere som må adresseres før hjemmesykehus kan skaleres på en bærekraftig måte (Moland et al. 2026).

3.3 Kvalitet og effektivitet

Erfaringer fra pilotprosjekter viser at hjemmesykehus i stor grad begrunnes med økt kvalitet og pasienttilfredshet. Mindre fokus på sykdom, mindre risiko for smitte, mer aktivitet og mer normal hverdag er effekter av hjemmesykehus som kan bedre både opplevelsen av behandling og pasientens helse (Cheng et al. 2025; He et al. 2026). Samtidig er økt kapasitet en nødvendig forutsetning for at hjemmesykehus skal være bærekraftig over tid. I et helsevesen under press må tjenesten bidra til mer effektiv ressursbruk, ikke bare bedre pasientopplevelse.

Selv om fokus på kvalitetsheving eller økt effektivitet kan være en nødvendig prioritering, trenger ikke den ene gå på bekostning av den andre. Dersom økt kvalitet på behandlingen bidrar til færre fremtidige innleggelser vil det senke belastningen på helsevesenet. I tillegg er det potensielt mange sparte kostnader knyttet til å flytte behandling ut av sykehuset. Driftskostnader på mat, vask og skifte av sengetøy kan spares på dersom innleggelse på sykehus utgjør en andel av behandlingen, se vedlegg A.

Det eksisterer tiltak med behandling i hjemmet som også fokuserer på å spare ressurser. "Unngå innleggelse" er en strategi som brukes både i Norge og internasjonalt, der man målrettet jobber for å unngå at pasienten legges inn på sykehus, for eksempel ved å gjøre korttidsbehandling i hjemmet. Det finnes eksempler på at tiltak under denne strategien kan bidra til både færre innleggelser og reduserte kostnader (He et al. 2026; Kongsberg kommune 2026; Rijal et al. 2026).

3.4 Teknologi

Medisinsk teknologi er en sentral forutsetning for å flytte behandling ut av sykehuset. Behovet for teknologi er todelt. Det første handler om behandlingsstøttet teknologi: IV-pumper, fjernstyrte kameraer og digital hjemmeoppfølging gjør det allerede mulig å gi avansert behandling utenfor sykehuset (G. Karlsen 2026; L. Karlsen 2026). Det andre handler om diagnostikk utenfor sykehuset. For at helsepersonell skal kunne ta faglig forsvarlige beslutninger om pasientens forløp uten at pasienten må innom sykehuset, trengs verktøy for blodprøvetaking, blodgass og billeddiagnostikk tilgjengelig utenfor sykehusets vegger (Personlig kommunikasjon, K. Holbø).

Medisinsk behandlingsteknologi kan både omfatte aktiv behandlingsstøtte, og passiv monitorering som kontinuerlig registrerer pasientens tilstand uten at helsepersonell trenger å være til stede. SamSår og digital oppfølging med hodekamera er eksempler på et prosjekter der det er utviklet teknologi og løsninger tilknyttet sårbehandling (Helse Sør-Øst RHF 2026; G. Karlsen 2026). SamSår baserer seg på digitale videokonsultasjoner mellom kommunal sykepleier og spesialist, kombinert med standardiserte prosedyrer og kompetansedeling. Til sammen bidrar det til at pasienter med kroniske eller komplekse sår kan følges opp hjemme på en måte som både øker mestring og frigir kapasitet på sykehuset (Helse Sør-Øst n.d. Sørli 2026). I den andre enden finner vi løsninger som Vitalthings Guardian H10, som bruker sensorer til nattlig monitorering av for eksempel KOLS-pasienter. Denne typen teknologi kan bidra til direkte reduksjon i behovet for kontinuerlig menneskelig bemanning (Vitalthings n.d.). Et annet eksempel på kapasitetsbesparende teknologi er maskinlæring som er tatt i bruk for å identifisere brudd på røntgenbilder ved Drammen sykehus, noe de anslår kan frigjøre 5500 legekonsultasjoner årlig (Vestre Viken HF 2023).

Selv om teknologi innen behandling er viktig, er det et like stort behov for teknologi for å gjen-

nomføre diagnostikk i felt. Helsepersonell er avhengig av verktøy som gjør det mulig å ta en faglig forsvarlig beslutning om pasientens forløp, dersom ønsket er å redusere antall pasienter som må innom sykehuset. Det kan for eksempel innebære å ta prøver av blod, blodgass, eller røntgen. I dag er det store utfordringer knyttet til denne typen prøvetaking i distriktene, men det er enkelte initiativer som tar et steg i riktig retning. For eksempel har Vestre Viken utviklet en tjeneste for mobil røntgentaking på syke- og omsorgsboliger, der de flytter utstyret til pasienten (Vestre Viken HF 2024). Nye teknologiske løsninger kan potensielt tilrettelegge for at langt flere behandlingsforløp kunne starte og fullføres i hjemmet.

Likevel er det en gjennomgående utfordring at teknologien i stor grad utvikles med uten å ta det helheten i betraktning. I forbindelse med SamSår-prosjektet utviklet de en egen utstyrs koffert for sårbehandling, men under implementering oppdaget de at hjemmesykepleien allerede opererte med seks ulike koffertter med medisinsk utstyr (Sørli 2026). Sammensetningen av parallelle løsninger og teknologi blir dermed en stor barriere for at hjemmebehandling skal fungere godt. Det er derfor viktig at teknologiske innovasjoner i helsetjenesten ikke bare løser enkeltproblemer, men tilpasses det overordnede systemet over tid.

3.5 Samarbeid mellom sykehus og kommune

Nært sagt samtlige intervjuobjekter og deltakere på Hjemmesykehus Landskonferansen understreker at godt samarbeid mellom sykehus og kommune er en forutsetning for hjemmesykehus. Dette understreker også en tydelig ansvarsfordeling, der sykehuset ivaretar det formelle medisinske ansvaret, men samarbeider med kommunen om gjennomføringen. Kongsberg kommunes "72 timers utvidet oppfølging etter sykehusinnleggelse" illustrerer effekten av små tiltak for bedre samhandling. Der har de åpnet opp for at ansatte i kommunehelsetjenesten kan kontakte lege på medisinsk avdeling i 72 timer etter pasienten er skrevet ut, og bidrar til å redusere unødvendige innleggelser som kommer av uklarhet i overgangen (Kongsberg kommune 2026; Kristoffersen 2026).

For St.Olavs Hospital er det viktig å tenke bredt, slik at et hjemmesykehus gir et godt tilbud til innbyggere både i Trondheim og i kommuner med lang avstand til sykehus. Kommunehelsetjenesten i Trondheim kommune opererer under et betydelig kapasitetspress og har utfordringer med rekruttering til hjemmesykepleien. Den primære utfordringen er ikke finansielle ressurser, men tilgang på arbeidskraft, se vedlegg E. Selv om Trondheim kommune er positive til samarbeid med St.Olavs, er det viktig at en hjemmesykehusmodell ikke baserer seg på å utnytte en kapasitet hos kommunen ikke har. I distriktene er det et litt annet bilde, der utfordringene med kapasitet hos hjemmesykepleien ikke er like omfattende. I tillegg utføres allerede avanserte prosedyrer som IV-behandling i mange distriktkommuner av hjemmesykepleiere. Dette skjer imidlertid uten formelle rammer rundt ansvar og økonomi, men gjennom lokale avtaler som har vokst frem av praktiske hensyn (Personlig kommunikasjon, hjemmesykepleier fra Aukra, 22.april 2026).

3.6 Pårørende

Pårørende utgjør i dag en sentral og nødvendig ressurs som må inkluderes ved implementering av hjemmesykehus. Ifølge Pårørendealliansen er deres innsats verdt 63,4 milliarder kroner, som tilsvarer rundt 140 000 årsverk, på et nivå med om lag 100 000 sykepleiere (Pedersen et al. 2025). Dette synliggjør hvilken betydelig rolle pårørende allerede har i helsetjenesten, og hvordan hjemmesykehus i praksis bygger videre på denne innsatsen. Samtidig fremheves hjemmesykehus som et tiltak som kan bidra til økt kvalitet i behandlingen. Muligheten til å oppholde seg i sitt eget hjem kan legge til rette for mer tid sammen med pårørende og en mer normalisert hverdag for både pasient og familie. Dette gjør seg særlig gjeldene i palliative forløp, hvor nærhet, trygghet og tilstedeværelse har stor betydning.

For at hjemmesykehus skal lykkes, må det være en tydelig ansvarsfordeling (Helsedirektoratet 2021b). Erfaringer fra pårørende viser at de kan oppleve å overta oppgaver som i utgangspunktet ligger til kommunale tjenester, og dermed påtar seg en stor psykisk og fysisk belastning (Terjesen 2026). Uten tydelige ansvarsavklaring mellom sykehuset og kommunene er det en risiko for at

hjemmesykehuset utvikles til en løsning hvor belastningen i for stor grad overføres til pårørende.

Videre rapporterer flere pårørende at de i begrenset grad blir involvert i beslutningsprosesser eller lyttet til i gjennomføringen av helsetjenester. Dette peker på behovet for å stryket samhandling mellom nivåene i helsetjenesten, med mål om å sikre kontinuitet, forutsigbarhet og tilstrekkelig støtte. En viktig forutsetning for å redusere belastningen er at det foreligger en forsikring for åpen retur til sykehuset. Erfaringer fra etablerte hjemmesykehusordninger i Norge viser at muligheten for rask reinnleggelse er et sentralt tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og trygghet i behandlingsforløpet, se vedlegg B.

Det økonomiske presset utgjør også en sentral utfordring. Omsorgsrollen medfører ofte både økte utgifter og redusert inntekt, samtidig som eksisterende støtteordninger ikke er tilstrekkelige (Pedersen et al. 2025). Dette kan føre til at pårørende må redusere yrkesdeltakelse eller ta permisjon for å ivareta omsorgsansvaret. Hjemmesykehus kan bidra til økt kvalitet av pasientbehandling, men forutsetter at belastningen for pårørende ikke bli for stor. Tydelig ansvarsfordeling, reell involvering og bærekraftig betingelser må til for en forsvarlig og langsiktig implementering.

3.7 Oppsummering

Til tross for økende politisk og faglig støtte til hjemmesykehus, finnes det idag ingen helhetlig og bærekraftig modell hvordan sykehuset og kommunen skal samarbeide om hjemmesykehus. Dagens finansieringssystem ISF skaper lite tilrettelegging for samhandling, teknologiske løsninger er fragmenterte og det mangler tydelige organisering for ansvarsfordeling og ressursflyt mellom aktørene. I tillegg er kapasitet i kommunehelsetjenesten og belastning av pårørende en begrensende faktor. Dette peker mot at potensialet for hjemmesykehus er til stede, men at det krever strukturelle grep for å realiseres. Det er dette den strategiske analysen tar utgangspunkt i.

4 Utarbeidelse av mulighetsrom

Organiseringen av samarbeidet mellom sykehus, kommune og hjem er like avgjørende som selve behandlingen som flyttes. Videre analyse og utforming av strategi tok derfor utgangspunkt i spørsmål knyttet til samhandling mellom tjenestenivåer, ressursbruk, geografiske forutsetninger og integrering av nye behandlingsmodeller i eksisterende tjenester.

Bearbeidingen av innsikten fulgte en iterativ prosess der tidlige observasjoner gradvis ble strukturert, utforsket og analysert i lys av nye perspektiver. Denne prosessen ledet til to ulike strategiske muligheter for hvordan hjemmesykehus kan organiseres ved St. Olavs Hospital.

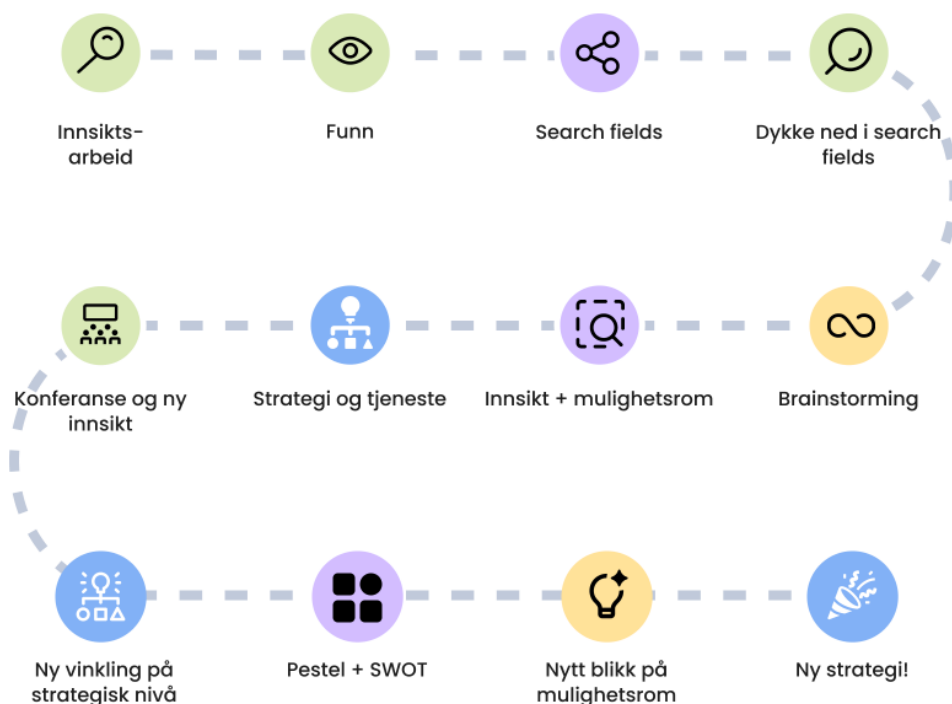


Figure 1: Illustrert prosess fra innsikt til strategisk retning

4.1 Utforskningsområder

De første analysene tok utgangspunkt i å identifisere gjengangere på tvers av intervjuer, dokumenter og observasjoner. Temaer som finansiering, samhandling, teknologi, geografiske hensyn og pårørendebelastning dukket opp på tvers av informanter og kilder. Disse observasjonene ble først samlet som løse notater, deretter sortert i tematiske klynger som utgjorde grunnlaget for videre utforskning.

Fellesnevnerne ble strukturert videre til avgrensede utforskningsområder. Hvert felt representerte et strategisk spørsmål eller en systemisk utfordring som krevde dypere undersøkelse. Eksempler på slike felt var: hvordan hjemmebehandling kan organiseres uten å bli avhengig av ildsjeler, hvordan finansieringsmodeller påvirker samhandling mellom forvaltningsnivåer, og hvordan teknologi kan støtte behandling på avstand.



Figure 2: Fra fellesnevnerne til utforskningsområder

4.2 Fordypning og idegenerering

Hvert område ble utforsket gjennom målrettet research, gjennom henvendelser til informanter, analysering av finansieringsregelverk og organisatoriske modeller, og kartlegging teknologiske løsninger i bruk i Norge og internasjonalt. Parallelt ble det gjennomført idegenereringsøvelser for å utvikle potensielle tjenestekomponenter. Det ble tidlig klart at tjeneste og strategi ikke kunne utformes uavhengig av hverandre. Strategien bestemmer hva slags tjeneste som er mulig å tilby, mens tjenesten avgjør om strategien er bærekraftig i praksis.

4.3 Første strategiske retning: Innleggelse som utgangspunkt

Den første strategiske retningen tok utgangspunkt i en modell der pasienten er formelt innlagt ved St. Olavs Hospital, men oppholder seg hjemme. En slik modell gir samme ISF-kompensasjon som ordinær sykehusinnleggelse, samtidig som en seng frigjøres. For den enkelte pasienten vil det også være besparelser av kostnader tilknyttet rengjøring, mat og annen vedlikehold på sykehuset.

Strategien legger opp til en trinnvis utvikling der distriktsmodellen skulle etableres først, etterfulgt av en modell for Trondheim. Tjenesteforslaget for denne strategiske retningen inkluderte tverrfaglige oppfølgingsteam, delte stillinger mellom sykehus og kommune, og styrking av ambulansetjenesten for å ha en andel vakter i oppfølging på hjemmesykehus. Modellen er tydelig avgrenset til å omfatte pasienter som behøver innleggelse. Den legger ikke opp til å unngå innleggelse eller følge opp pasienter i overgangen mellom sykehus og kommune.

Figur 3 viser de to tiltakene som utgjør kjernen i distriktsmodellen. Delte stillinger sikrer spesialistkompetanse lokalt, mens en styrket ambulansetjeneste gjør det mulig å ha sykehusansatte på daglig visitt hos hjemmesykehuspasientene. Figur 4 illustrerer modellen for Trondheimsnære områder. Den baserer seg på en tverrfaglig avdeling som arbeider med oppfølging i hjemmet på tvers av diagnoser og avdelinger.

Fase 1: Hjemmesykehus i distriktet

To tiltak kombineres for å gjøre daglig spesialistoppfølging mulig uten daglig reise fra St. Olavs.

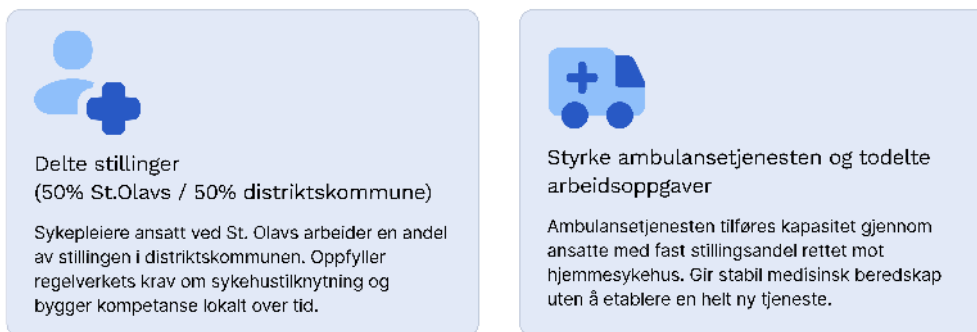


Figure 3: Fase 1: Hjemmesykehus i distriktet

Fase 2: Hjemmesykehus introduseres i Trondheim

Når distriktsmodellen er stabil og erfaringsgrunnlaget er tilstrekkelig, utvides hjemmesykehus til Trondheimsnære områder. Kunnskap og prosedyrer fra fase 1 reduserer oppstartsrisiko i Trondheim.



Figure 4: Fase 2: Hjemmesykehus introduseres i Trondheim

4.4 Vendepunkt: Landskonferansen for hjemmesykehus

I slutten av april 2026 deltok gruppen på Landskonferansen for hjemmesykehus i Kristiansund. Konferansen ga et bredere systemperspektiv enn tidligere. Presentasjoner fra ulike deler av Norge og Norden viste at hjemmesykehus i stor grad begrunnes med kvalitetsøkning: pasienter blir raskere friske hjemme, opplever mindre fokus på sykdom og rapporterer høyere tilfredshet. Ressursbesparelse ble ikke trukket frem som primær motivasjon, men heller som en positiv konsekvens av gjennomføring av enkelte prosjekter.

En viktig inspirasjonskilde på konferansen var innlegg om initiativer som viste at hjemmesykehus kan være mer enn vår opprinnelige tolkning av begrepet. Tiltak rettet mot å unngå innleggelse eller flytte poliklinisk behandling hjem illustrerte et behov vi ikke hadde adressert i den første strategiske retningen. Slike tiltak krever fortsatt ressurser, men organiserer dem på en annen måte enn en tradisjonell innleggelse. Dette gjorde det tydelig at en modell avgrenset til innlagte pasienter var for snever. Mulighetsrommet for en strategi som dekker et større spekter av pasientforløp er stort, og har gode forutsetninger for samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten om ressursbesparende tjenester.

4.4.1 PESTEL-analyse

For å sette innsikten fra konferansen i et større perspektiv gjennomførte vi en PESTEL-analyse. Dette ga en strukturert oversikt over hvilke eksterne faktorer som ville påvirke utviklingen av hjemmesykehus ved St. Olavs.

P Politiske Støtte fra regjeringen Regjeringen ønsker en mer helhetlig helsetjeneste med mindre skille mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, økt digitalisering og desentralisering av kompetanse St.Olavs Stor støtte fra ledelsen på St.Olavs for HS Kommunal involvering Tidlig involvering av kommunen i prosessen reduserer risiko for ansvarsforskyvning og øker sjansen for bærekraftige løsninger Geografi Store geografiske avstander gir utfordringer med likeverdig helsetilbud	E Økonomiske ISF ISF belønner å ha pasienter innlagt på sykehuset. Kommunene har fast årlig støtte og har få økonomiske insentiver for samhandling med dagens finansieringsmodell Presset kapasitet Mangel på helsepersonell øker behovet for effektiv ressursbruk. Eldrebølgen vil presse kapasiteten i helsevesenet ytterligere Drift Store driftskostnader knyttet til det å ha pasienter innlagt på sykehus (mat, vask, sengetøy, osv.)	S Sosiale Trygghet og normal hverdag Flere pasienter ønsker å være hjemme for trygghet og mer normal hverdag. I tillegg kan reiseveien til sykehuset være utfordrende for mange pasienter. Fra andre land og prosjekter i Norge rapporteres det om økt pasienttilfredshet Forventninger fra pasienter Særlig blant eldre er det flere pasienter som ønsker å beholde den menneskelige kontakten i behandlingen
T Teknologiske Teknologi tilpasset i HS Utstyr som IV-pumpe, sensorer, hodekamera er allerede i bruk til behandling i hjemmet i Norge. Helseplattformen gjør tilgang til felles journal på tvers av tjenestenivå mulig Diagnostikk AI og maskinlæring brukes allerede i dag til å effektivisere diagnostikk. Det eksisterer også utstyr for å diagnostisere utenfor sykehuset Fragmentert leveranse Teknologien som benyttes i dag leveres av mange forskjellige aktører Datasikkerhet Økende digitalisering stiller høyere krav til datasikkerhet	E Miljømessige Pasientreiser Lange og hyppige reiser til sykehuset bidrar til utslipp	L Juridiske Uklare retningslinjer Kravene for at pasienten skal regnes som innlagt er uklare Pårørende Det mangler gode støtteordninger for pårørende hvor behandling/stell går utover arbeid, økonomi og helse Samarbeidsavtale Tydelige avtaler for ansvar og finansiering mellom sykehus og kommune er ikke på plass

Figure 5: PESTEL-analyse

PESTEL-analysen viser at utviklingen av hjemmesykehus skjer innenfor et helsevesen preget av både økende utfordringer på kapasitet og sterke politiske føringer mot mer hjemmebaserte og digitale tjenester. Politisk er det støtte for desentralisering av kompetanse, digitalisering og økt samhandling mellom tjenestenivåene. Samtidig utfordres helsevesenet av eldrebølgen, presset kapasitet og økende kostnader som skaper behov for mer bærekraftige helsetjenester. Analysen viser samtidig flere strukturelle barrierer for skalering av hjemmesykehus. Dagens finansieringsmodeller gir begrensede insentiver for samarbeid, ansvarsfordelingen mellom sykehus og kommune er uklar, og geografiske forskjeller gjør det vanskelig å etablere likeverdige tjenester. Samlet peker dette på at hjemmesykehus ikke primært er begrenset av teknologi, men av organisatoriske og strukturelle forhold i helsevesenet.

4.4.2 SWOT-analyse

S Styrker	W Svakheter	O Muligheter	T Trusler
Distriktskommuner Positiv innstilling til HS Gjør allerede avansert behandling Omstillingsvillige og tilpasningsdyktige Kompetanse innen hjemmebehandling Med fra start St.Olavs Erfaring med HS fra AHS Helseplattformen Støtte fra ledelsen for HS Spesialistkompetanse	Distriktskommuner Store avstander Presset kapasitet Mangel på spesialistkompetanse St.Olavs Noe skepsis blant leger Hierarkisk organisasjonsstruktur Jobber i siloer	Politisk fokus på digitalisering og desentralisering AI og ny teknologi kan effektivisere diagnostikk og behandling Mulighet for å utvikle nye nasjonale standarder Økende aksept for hjemmebehandling	Økende kostnader i helsevesenet Risiko for at kommuner får flere oppgaver uten tilstrekkelige ressurser Datasikkerhet og personvernrisiko ISF 2026 gir lite økonomiske insentiver for samhandling Varslet mangel på helsepersonell i fremtiden Avhengighet av lidsjeler for å drive HS fremover

Figure 6: SWOT-analyse

SWOT-analysen viser at hjemmesykehus har potensial til å redusere belastningen på sykehusene samtidig som pasienten kan få en mer fleksibel behandling. Erfaring fra St. Olavs, teknologisk utvikling, og økende politisk støtte gir et sterkt grunnlag for videre utvikling. En ledelse på St. Olavs som ytrer klart ønske om hjemmesykehus gir gode muligheter for at prosjektet ikke avhenger av dedikerte enkeltpersoner, noe som har vært en utfordring i blant annet utviklingen av AHS. Samtidig krever implementering av hjemmesykehus omfattende samhandling, ansvarsfordeling og kompetanseoverføring mellom spesialist og kommunalhelsetjenester. Presset kapasitet i både kommuner og sykehus gjør det utfordrende å bygge opp nye tjenester som krever store personellressurser.

4.5 Mulighetsrom

Analysene ga grunnlag for å se mulighetsrommet på nytt. PESTEL-analysen tydeliggjorde at hjemmesykehus opererer i et landskap der demografiske og økonomiske drivere krever systemendring, men der strukturelle barrierer fortsatt begrenser handlingsrommet. SWOT-analysen viste at St. Olavs har sterke forutsetninger for å lykkes, men at modellen må bygges for å redusere personavhengighet og belastning på kommunene.

Analysene bekreftet at den første strategiske retningen var for avgrenset. Strukturelle barrierer, personavhengighet og belastning på kommunene krevde en modell som tenkte bredere enn innleggelse alene. Dette ga grunnlag for å formulere en andre strategisk retning. De to strategiske retningene som har blitt vurdert underveis repeteres mer detaljert videre.

4.5.1 Strategisk mulighet 1: Innleggelse som utgangspunkt

I denne retningen er målet å først og fremst tilby tjenester der pasienten er innlagt ved St. Olavs, men oppholder seg hjemme. Oppfølging, ansvarslinjer og finansiering organiseres rundt denne strukturen. Det innebærer at sykehuset har det medisinske ansvaret gjennom hele forløpet, uavhengig av om pasienten bor i by eller distrikt. Samtidig forutsetter det god samhandling mellom sykehus og kommune, og tydelige fordelingsnøkler for oppfølgingen som skjer gjennom kommune.

For distriktene baserer retningen seg på å fysisk flytte spesialistkompetanse ut i distriktene, enten gjennom personell med tilknytning til sykehuset, eller personer som allerede er til stede lokalt.

Modellen har noen klare fordeler. Den passer godt inn i ISF 2026, fordi pasienten er registrert som innlagt og oppfølgingen skjer av sykehuspersonell. For avdelinger som allerede har erfaring med hjemmebehandling, som AHS barn, bygger den på en kjent arbeidsform. Noen utfordringer er å sørge for tilstrekkelig breddekompetanse blant helsepersonell i distriktene, samt god koordinering av de involverte. Samtidig omfatter modellen kun pasienter som behøver innleggelse. Den tar ikke for seg pasienter som kunne unngått innleggelse helt, eller med overgangen fra sykehus til kommune etter utskrivning.

4.5.2 Strategisk mulighet 2: Utvidet hjemmesykehus

Denne retningen er en strategi der St. Olavs satser på to ting samtidig. For det første at vurderingen om en pasient kan behandles hjemme kan tas av helsepersonell lokalt, uten at pasienten må sendes inn til sykehuset først. For det andre at pasienter som allerede er på sykehuset, enten poliklinisk eller innlagt, kan sendes hjem tidligere enn i dag. I begge tilfeller er trygg overgang til hjemmebehandling avgjørende. Det forutsetter at spesialistkompetanse er tilgjengelig utenfor sykehuset, og at det finnes en tydelig struktur for samarbeid mellom sykehus og kommune. Modellen forutsetter også teknologisk utvikling over tid, ettersom diagnostikk og behandling som i dag krever fysisk oppmøte på sykehuset gradvis må kunne gjennomføres enten hjemme hos pasienten eller via digitale løsninger.

Denne modellen er mer sammensatt enn den første. Den krever tett samarbeid mellom sykehus og kommune, og strukturelle endringer som beveger seg bort fra snevre ansvars og kommunikasjonslinjer. Til gjengjeld dekker den et bredere felt: unngå innleggelse, tidlig utskrivning og trygg overgang i én og samme organisering.

4.6 Avgjørende veivalg

Strategisk retning 2 ble valgt som grunnlag for den strategiske anbefalingen. Ved innleggelse hjemme, slik retning 1 beskriver, stiller dagens regelverk høye krav til hva hjemmesykehus må være. For at pasienten skal være formelt innlagt, kreves daglig kontakt med sykehuspersonell, og kontakten skal i hovedsak være fysisk (Helsedirektoratet 2025b). Det forutsetter kompleks logistikk og koordinering på avstand, som ingen avdeling ved St. Olavs har erfaring med i stor skala. I tillegg er modellen avgrenset til pasienter som allerede er innlagt, og adresserer verken overgangen fra sykehus til kommune eller muligheten for å unngå innleggelse helt. Dette utgangspunktet innebærer dermed å start med det som krever mest, før de grunnleggende strukturene er på plass.

Strategisk retning 2 tar i stedet utgangspunkt i å etablere strukturene som gjør hjemmebehandling mulig. Dette innebærer samhandlingsstrukturer, kompetansedeling og organisatorisk forankring mellom tjenestenivåene, som til sammen skaper et grunnlag for hjemmebehandling. Ved å inkludere et bredt spekter av pasienter, også de som ikke krever innleggelse og daglig visitt, kan oppstarten i den enkelte kommunen tilpasses de pasientene som faktisk har behov for å være hjemme. Erfaringene som bygges opp i denne fasen rundt samhandling, teknologi og pasientutvelgelse, er erfaringer som på sikt gjør innleggelse hjemme mulig. Innleggelse hjemme er derfor ikke utelukket fra modellen, men blir en naturlig mulighet der strukturene er på plass. På den måten behøver man ikke løse det mest komplekse problemet først for å komme i gang.

5 Strategisk retning

Strategien som beskrives i dette kapittelet belager seg på en bred forståelse av begrepet "hjemmesykehus". Målet er å bygge strukturer som gjør hjemmebehandling mulig for et bredt spekter av pasienter. Kapittelet beskriver hvilke prinsipper strategien bygger på, hvordan den tilpasses ulik geografi, hvilke pasientgrupper den retter seg mot, og hvordan den er tenkt å utvikle seg over tid.

5.1 Kjerneprinsipper

St. Olavs Hospital etablerer et hjemmesykehussystem som kombinerer to strategier: unngå innleggelse og tidlig utskrivelse. Målet er å flytte kompetanse og teknologi nærmere pasienten slik at flere kan behandles trygt hjemme, samtidig som kapasiteten på sykehuset frigjøres. Dette er ikke en rendyrket hjemmesykehusmodell der spesialisthelsetjenesten overtar alle oppgaver i hjemmet, men et bevisst valg om å styrke samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste der begge nivåer bidrar og deler kompetanse.

Strategien adresserer et kritisk gap i dagens system. Hjemmesykepleien tilbyr oppfølging i hjemmet, men mangler ofte den spesialiserte kompetansen og faglige støtten som kreves for pasienter med akutte eller komplekse tilstander. Sykehuset på sin side holder i mange tilfeller pasienter unødvendig lenge fordi alternativet er fullstendig utskrivelse til kommunal omsorg uten tett sykehusoppfølging. Særlig eldre, kronisk syke og pasienter med sammensatte lidelser har høy risiko for reinnleggelse kort tid etter utskrivelse (Danielsen and Fjær 2020), noe som skaper frykt for å skrive ut for tidlig. Uklar fordeling av ansvar mellom tjenestenivåene forsterker problemet (Helsedirektoratet 2021b). Hjemmesykehus skal være det manglende bindeleddet som kombinerer behandling i hjemmet med direkte tilgang til spesialistkompetanse fra sykehuset, og som formaliserer ansvarsdelingen mellom tjenestenivåene.

Unngå innleggelse innebærer at ambulanse, legevakt og fastlege får kapasitet og verktøy til å vurdere om pasienten kan behandles hjemme fremfor å legges inn. Dette krever bedre diagnostisk utstyr i ambulansen og et standardisert kartleggingsskjema for funksjonsnivå. Samnanger kommune har utviklet et slikt verktøy gjennom sitt HPH 0-skjema, som systematisk kartlegger pasientens kognitive funksjon, mestring i hverdagen, bolig og hjelpemidler, familie og nettverk, samt rehabiliteringsbehov (KS n.d.). Skjemaet gir helsepersonell i førstelinje grunnlag for å vurdere om pasienten kan behandles trygt hjemme, hva som krever støtte, og pårørendes kapasitet til å bidra.

Tidlig utskrivelse handler om å bygge systemer som gjør det trygt å skrive ut pasienter tidligere enn dagens praksis tillater. Forskning viser at reell samhandling mellom sykehus og kommune i overgangsfasen kan forebygge reinnleggelse (Danielsen and Fjær 2020). Dette krever imidlertid tidlig varsel om behov for kommunale tjenester, god kommunikasjon mellom tjenestenivåene, og tydelige avtaler om oppfølging (Helsedirektoratet 2021b). Strategien forutsetter tett oppfølging de første døgnene etter utskrivelse, tilgjengelig kompetanse på kort varsel, og teknologistøtte som muliggjør overvåking og behandling hjemme.

Strategien formaliserer mye av det som allerede skjer uformelt i distriktene. Som beskrevet i kapittel 2.6, utfører mange kommuner intravenøs behandling i hjemmet uten formell støtte fra sykehuset. Strategien anerkjenner denne virkeligheten og skaper rammer som sikrer at slik praksis får faglig oppfølging, finansiering og juridisk forankring. Begge strategiene forutsetter tett samarbeid mellom aktører som tradisjonelt opererer separat, og gir sammen et reelt alternativ mellom «bli hjemme uten oppfølging» og «full sykehusinnleggelse».

5.2 Prioriterte pasientgrupper

Pasientgruppene som presenteres her er hentet fra konseptutredningen som pågår parallelt ved St. Olavs, og bygger på klinisk erfaring fra leger og fagpersonell ved sykehuset (personlig kommunikasjon, Kristine Holbø). De er primært vurdert med tanke på innleggelsesbasert hjemmesykehus. For strategien som anbefales i denne rapporten, der også poliklinisk behandling hjemme inngår i like

stor grad, kan andre pasientgrupper være vel så aktuelle.

- **Lungemedisin:** KOLS-forverring, infeksjoner, palliasjon.
- **Medisinsk klinikk:** Infeksjoner, palliasjon, cytostatika.
- **Nevroklinikk:** Infusjonsbehandlinger.
- **Kreftklinikk:** Infeksjoner, palliasjon, flerdagers cellegiftkurer.

Felles for gruppene er at de har behov for spesialisert medisinsk oppfølging, men at tilstanden er stabil nok til at behandlingen kan gjennomføres forsvarlig utenfor sykehus med riktig tilrettelegging og faglig støtte (St. Olavs hospital 2025), se også vedlegg D.

5.3 Hjemmesykehus i fremtiden

Hjemmesykehus ved St. Olavs Hospital vil ikke etableres over natten, men gjennom en planlagt utvikling over tid. Modellen forutsetter også teknologisk utvikling over tid, ettersom diagnostikk og behandling som i dag krever fysisk oppmøte på sykehuset gradvis må kunne gjennomføres enten hjemme hos pasienten eller via digitale løsninger.



Figure 7: Implementeringsforløp for hjemmesykehus

Fase 1: Etablering av grunnlag (0–3 måneder)

Den første fasen handler om å legge det organisatoriske og metodiske grunnlaget. St. Olavs etablerer et sentralt hjemmesykehus-team med tverrfaglig kompetanse. Teamet bemannes gjennom delte stillinger, der helsepersonell jobber både på avdeling og i hjemmesykehus. Dette opprettholder fagkompetansen på avdeling, bygger kompetanse på hjemmebehandling og skaper en kulturell bro mellom sykehus og kommune.

Parallelt utvikles et standardisert kartleggingsskjema inspirert av Samnanger kommune sitt HPH 0-skjema KS n.d. Skjemaet skal gi helsepersonell i førstelinje et strukturert grunnlag for å vurdere om pasienten kan behandles trygt hjemme, hva som krever støtte, og pårørendes kapasitet til å bidra. Uten et slikt verktøy mangler man metode for å skille mellom pasienter som kan behandles hjemme og de som trenger sykehusinnleggelse.

I denne fasen kartlegges også eksisterende teknologi som kan tas i bruk umiddelbart: IV-pumper, sensorer for hjemmeovervåking, hodekamera for digital veiledning og diagnostisk utstyr i ambulanse. Samtidig inngås formelle samarbeidsavtaler med pilotkommunene.

Fase 2: Parallelle piloter (3–18 måneder)

Strategien bygger på tre parallelle piloter som tester modellen i ulike kontekster. Dette gir læring om hva som fungerer i by kontra distrikt, og hvor utfordringene oppstår.

Pilot 1: Trondheim (bymodell). I Trondheim testes teknologistøttet behandling og fleksibel oppfølging. Fokuset er på pasienter som bor nært sykehuset, der logistikken er enkel og responstiden kort. Her piloteres også varierende oppfølgingsintensitet: fra daglig kontakt med sykehuset til ukentlig oppfølging, avhengig av pasientens behov. Kartleggingsskjemaet testes i praksis ved akuttmottak og hos fastlege.

Pilot 2A: Røros (distrikt med etablert infrastruktur). Røros har siden 2018 hatt en helsevaktbil bemannet med ambulansepersonell som utfører både akuttoppdrag og kommunale oppgaver (Hofstad 2021). Denne eksisterende infrastrukturen gjør Røros til en naturlig pilotkommune. I hjemmesykehus-piloten kobles Røros-helsevakten til det sentrale teamet på St. Olavs, slik at ambulansearbeideren får digital støtte fra spesialister når det trengs. Dette tester om modellen fungerer på lang avstand fra sykehuset, og dokumenterer verdien av reduserte pasientreiser.

Pilot 2B: Hitra (distrikt uten etablert infrastruktur). Hitra representerer den vanskeligste konteksten: en øykommune med lang reisevei til sykehuset. Her må helsevakt-modellen etableres fra bunnen av, i samarbeid med Orkdal legevaktsentral som allerede betjener kommunen. Hitra er valgt fordi kommunen allerede deltar i St. Olavs arbeidsgruppe for hjemmesykehus, og fordi piloten vil synliggjøre verdien av hjemmesykehus der behovet er størst.

Ved å teste i tre ulike kontekster samtidig får man sammenlignbar læring om hva som fungerer universelt, og hva som må tilpasses lokale forutsetninger.

Fase 3: Dokumentasjon og læring (18–36 måneder)

Dokumentasjonsfasen handler om å samle kvantitative og kvalitative data fra de tre pilotene. Kvantitativt måles reinnleggesrater, antall unngåtte innleggelser, liggetid, kostnader og pasientreiser. Kvalitativt innhentes erfaringer fra pasienter, pårørende og helsepersonell. Kartleggingsskjemaet justeres basert på hva som faktisk predikerer vellykkede hjemmebehandlinger.

Parallelt med dokumentasjonsarbeidet pågår dialog mellom St. Olavs og Helsedirektoratet om endring av ISF-regelverket. St. Olavs er allerede i samtaler om å få godkjent digital oppfølging med spesialist som innleggelse i finansieringssystemet. Pilotdataene fra denne fasen vil styrke argumentasjonen med konkrete tall på effekt og kvalitet.

Fase 4: Regelverksendring og tidlig skalering (3–5 år)

ISF-regelverket representerer en kritisk avhengighet for full distriktsskalering. Uten godkjenning av digital oppfølging som innleggelse vil distriktsmodellen mangle finansieringsgrunnlag. Politisk prosess mot Helsedirektoratet og Stortinget tar tid, men St. Olavs rolle er å dokumentere at tilsvarende kvalitet kan leveres på avstand.

Samtidig som ISF-prosessen pågår, kan skalering starte i trondheimsnære kommuner som Skaun, Melhus og Malvik. Disse kan underordnes by-modellen ettersom de er i relativ nærhet til St. Olavs. Dette gir ytterligere dokumentasjon og erfaring mens man venter på regelverksendring.

Når ISF-regelverket er endret, kan full distriktsskalering akselerere.

Fase 5: Akselerert distriktsskalering (4–7 år)

Med ISF-godkjenning på plass kan hjemmesykehus rulles ut i hele distriktet. Helsevakt-modellen etableres i flere kommuner: Rennebu og Oppdal på fastlandet, Frøya og Ørland langs kysten. Teknologien standardiseres for å unngå fragmentering, der ulike kommuner bruker ulike systemer som ikke snakker sammen. Kompetanse overføres til kommunale sykepleiere gjennom opplæring fra det sentrale teamet, og ansvarsfordeling mellom sykehus og kommune formaliseres juridisk og økonomisk.

Fase 6: Optimalisering og innovasjon (7–10 år)

I denne fasen går utviklingen fra å «flytte sykehusbehandling hjem» til å «designe behandling for hjemmet». Nye behandlingsformer utvikles som kun er mulige i hjemmet, der pasientens eget miljø og pårørende inngår som en ressurs. Teknologisk innovasjon akselererer: AI-støttet diagnostikk i ambulanse, prediktive modeller som forutsier reinnleggesrisiko, og bedre integrasjon mellom ulike digitale systemer. St. Olavs samarbeider med andre helseforetak om nasjonal spredning av modellen.

Fase 7: Etablert standard (10–15 år)

På lang sikt handler det om kulturendring. Hjemmesykehus blir integrert i grunnutdanningen for sykepleiere, leger og ambulansepersonell. Yngre helsepersonell kjenner ikke til en tid uten hjemmesykehus, og pasienter forventer behandling hjemme som standard når det er forsvarlig. Kartleggingsskjemaet er en selvfølgelig del av akuttmedisinsk vurdering. Spørsmålet er ikke lenger «kan denne pasienten behandles hjemme?» men «må denne pasienten være på sykehus?». Hjemmesykehus er blitt «slik vi gjør det».

6 Tjenestekonsept

Dette kapittelet beskriver hvordan tjenesten hjemmesykehus kan se ut i henhold til den anbefalte strategien. Tjenestekonseptet bygger på en kombinasjon av å unngå innleggelse og tidlig utskrivelse som ett integrert system som opererer under en felles struktur. Pasienter på hjemmesykehus kan ha to ulike statuser: noen er formelt innlagt med sykehuset som behandlingsansvarlig, men oppholder seg hjemme fremfor på sengepost, mens andre følges opp poliklinisk uten formell innleggelse. Hvilken status som er aktuell avhenger av behandlingsbehov, funksjonsnivå og hjemmesituasjon, og avgjøres i samråd med pasienten.

For å illustrere hvordan tjenesten fungerer i praksis, følger vi Kari, 72 år, som bor på Hitra. Forløpet hennes er ett eksempel på hvordan man kan unngå fysisk innleggelse, og heller motta spesialisthelsebehandling på hjemmesykehus. Komponentene som gjør dette mulig beskrives i de påfølgende delene.

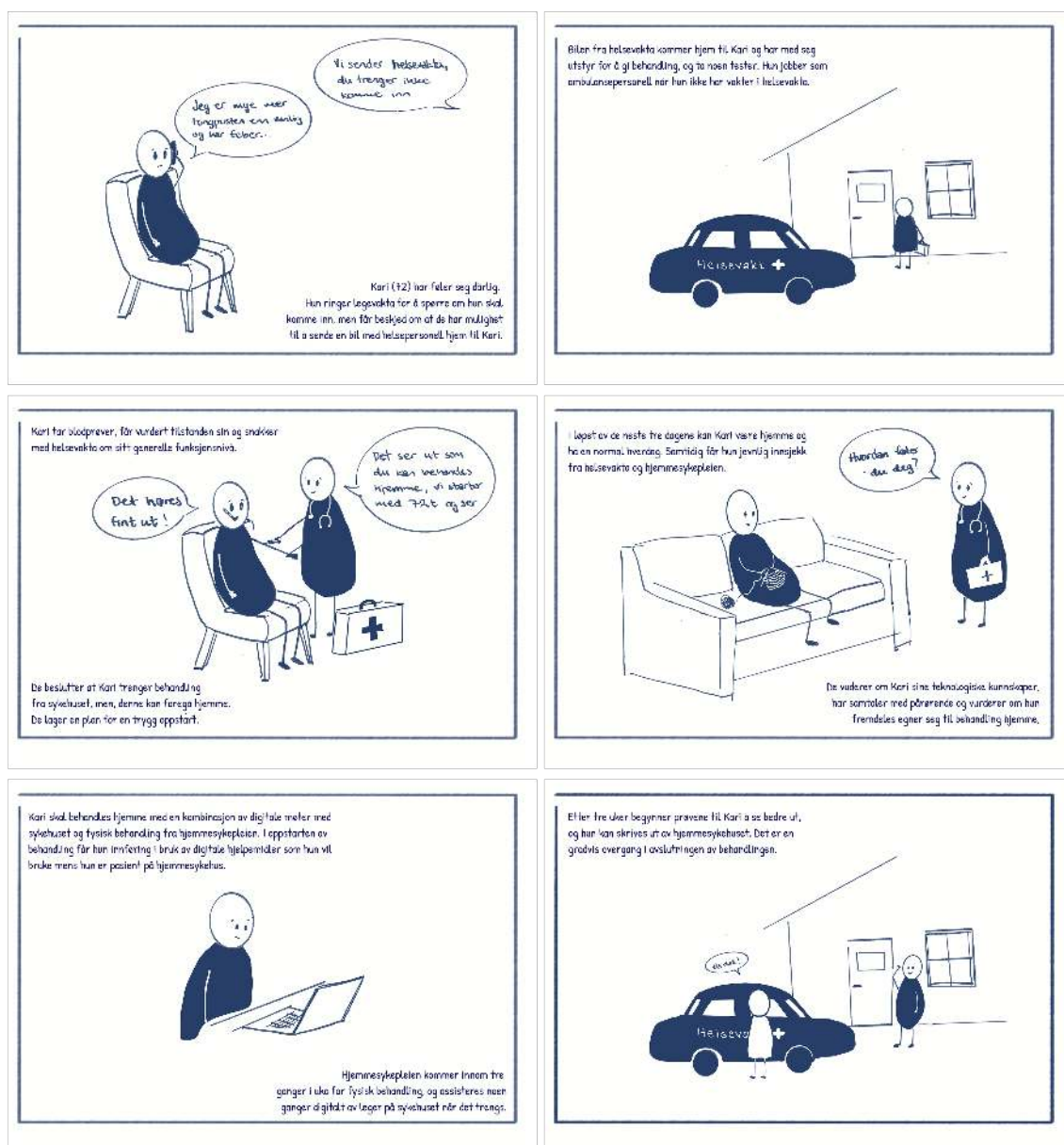


Figure 8: Brukerreise: Tjenesten fra pasienten sitt perspektiv

Figuren under viser den samme tjenesten fra systemets perspektiv, med beslutningspunkter og forgreiningspunkter fra første kontakt til avsluttet behandling.

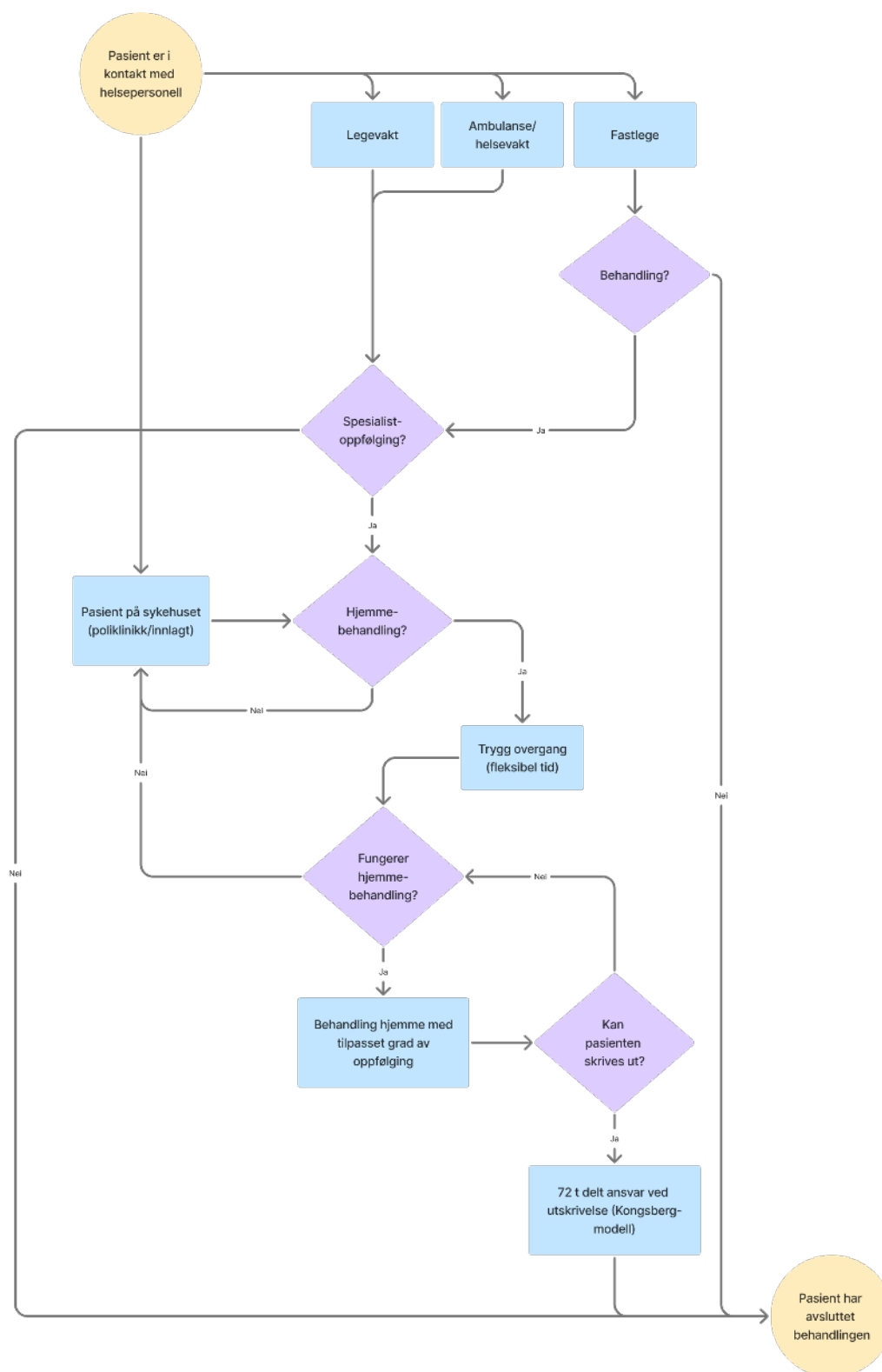


Figure 9: Flowchart som viser beslutningspunkter i tjenesten

6.1 Geografisk tilpasset tjeneste

For St. Olavs Hospital er det avgjørende å skalere hjemmesykehus tilbudet slik at det treffer pasienter både i Trondheim og i distriktskommunene. En identisk tjeneste er ikke mulig overalt. Likeverdige helsetjenester innebærer ikke lik organisering, men tilpasning til lokale forhold (Helse- og omsorgsdepartementet 2024). I Trondheim muliggjør korte avstander hyppige hjemmebesøk, effektiv ressursbruk og rask tilgang til sykehus ved forverring. Her kan personell ved St. Olavs selv stå for fysisk oppfølging, og modellen ligner i stor grad på hvordan AHS barn opererer i dag. I distriktskommuner med store geografiske avstander og spredt bosetting er dette en annen sak. Her vil den fysiske oppfølgingen ivaretas av lokalt personell, mens spesialistkompetansen fra St. Olavs tilgjengeliggjøres digitalt. Hvordan dette er konkret organisert beskrives i tjenestekomponentene under.

6.2 Tjenestekomponenter

Tjenesten involverer aktører fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Et dedikert koordineringsteam ved St. Olavs, hjemmesykehus-sentralen, har det overordnede medisinske ansvaret og fungerer som bindeleddet mellom sykehuset og de som møter pasienten hjemme. I Trondheimsregionen utfører sentralens eget personell fysisk oppfølging. I distriktene ivaretas den fysiske kontakten i all hovedsak av kommunal hjemmesykepleie. Fastlege, legevakt og ambulanse er sentrale i vurderingen av om pasienten er egnet for hjemmebehandling, og har alle mulighet til å henvise til hjemmesykehus. Pårørende er en aktiv del av oppfølgingen der det er kapasitet til det, men krever gode strukturer som også ivaretar de rundt pasienten. Komponentene nedenfor beskriver hvordan disse aktørene samhandler i praksis.

6.2.1 Hjemmesykehus-sentralen

Hjemmesykehus-sentralen er et dedikert team ved St. Olavs med overordnet koordineringsansvar for all hjemmebasert behandling i tilknytning til sykehuset. Teamet har to hovedoppgaver: pasientoppfølging for pasienter i Trondheimsregionen, og koordinering av behandling som skjer gjennom helsevaktene i distriktene. Fysisk oppfølging i Trondheimsnære områder vil på mange måter fungere slik som AHS barn fungerer i dag. I tillegg vil pasienter kunne henvises til sentralen fra legevakt, ambulanse og fastlege. De bistår i vurderinger av egnethet for hjemmebehandling, og legger den enkelte pasientens behandlingsplan. For distriktspasienter er rollen mer koordinerende, der sentralen veileder helsevaktene faglig og sikrer at behandlingen er som ønsket kvalitet.

Sentralen er tverrfaglig og består av personell fra avdelinger med pasientgrupper som er aktuelle for hjemmebehandling, som kreft, lunge og palliativt. Det vil være mulig å ha en kombinasjon av faste ansatte, og ansatte i delte stillinger. Både delte stillinger med andre sykehusavdelinger, og med hjemmesykepleien i Trondheim kan være aktuelt. Dette er et bevisst strukturelt valg som sikrer at fagkompetansen på avdeling opprettholdes og ikke tømmes over i en ny enhet, samtidig som sentralen får reell klinisk tyngde. Dette er en avdeling som ikke bare krever faglig bredde, men også ny kompetanse på digital oppfølging og hjemmebehandling. Kreftklinikken har fra tidligere god erfaring med delt stilling mellom hjemmesykepleien og sykehuset, se vedlegg D. Flere påpeker også at det kan være et viktig grep for å gjøre hjemmesykepleie mer faglig attraktivt, noe som er relevant i en tid der rekruttering er krevende. Delte stillinger forutsetter imidlertid geografisk nærhet, og er derfor beholdt personell lokalisert i Trondheimsregionen.

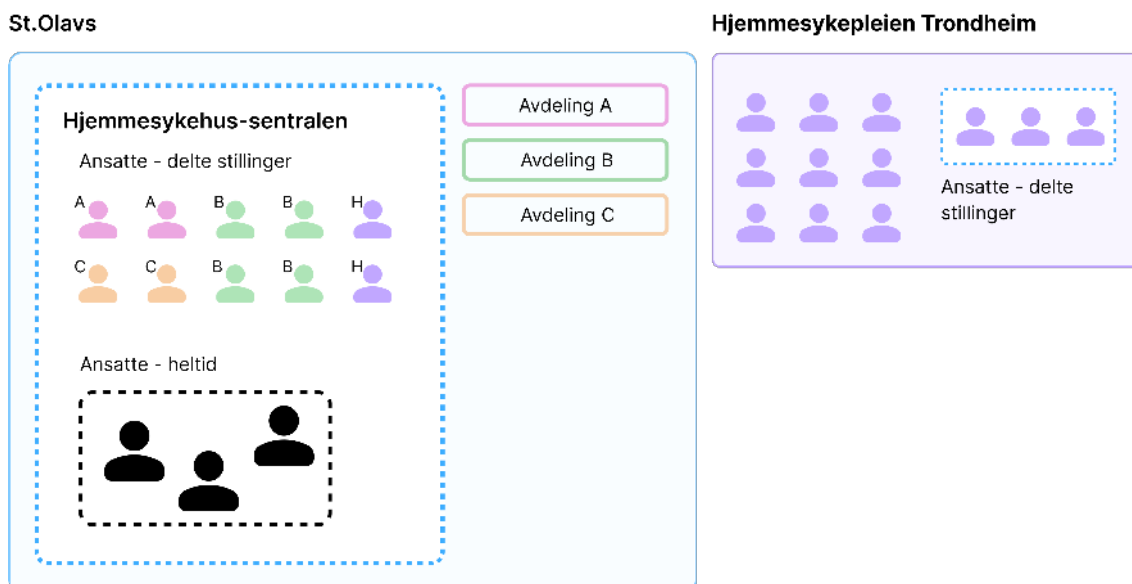


Figure 10: Visualisering av bemanning på hjemmesykehussentralen

6.2.2 Helsevakt

Helsevakten er en utvidelse av eksisterende pre-hospital tjeneste i distriktskommunene, og en lokal forlengelse av hjemmesykehus-sentralen ved St. Olavs. Røros og Lillehammer har godt etablerte eksempler på liknende løsninger med gode resultater (Helsedirektoratet 2020; NRK 2025). I Røros opererer helsevakta med ett kjøretøy bemannet av en ambulansearbeider, og fungerer som et alternativ til ambulanse ved henvendelser til 113. Når noen ringer inn, vurderes det om situasjonen krever ambulanse, eller om helsevakten kan rykke ut. Det gir en raskere og mer fleksibel respons for pasienter som ikke trenger akutt sykehusinnleggelse, men likevel trenger vurdering og eventuelt behandling på stedet (Helsedirektoratet 2020; Hofstad 2021). Disse modellene er viktige inspirasjonskilder til etablering av helsevakt ved alle ambulansestasjoner.

I hjemmesykehusmodellen får helsevakta en utvidet rolle, sammenlignet med hva den har i Røros. I tillegg til akutte utrykninger er de et sentralt kontaktpunkt i overgangsfasen når en pasient henvises til hjemmebehandling. De har muligheten til å gjennomføre hjemmebesøk for å kartlegge egnethet for hjemmebehandling. Dette er en omfattende vurdering som blant annet vil ta for seg funksjonsnivå, pårørendes kapasitet, eksisterende hjelpemidler, teknologiske ferdigheter og trygghet i hjemmesituasjonen, blant annet ved bruk av sjekklister (KS n.d.). I startfasen/overgangsperioden til hjemmebehandlingen vil helsevakten kunne gjennomføre strukturerte besøk, eller være støtte for oppstart med hjemmesykepleien.

Helsevakten vil være en forlengelse av ambulansestasjon og vil bestå av ansatte fra ambulansetjenesten, legevakt og hjemmesykepleien. En viktig forutsetning for tjenestekonseptet er at de pre-hospitale tjenestene styrkes med utstyr slik at de får muligheten til å gjøre mer omfattende tester og vurderinger i hjemmet. På den måten muliggjøres henvisning til hjemmesykehus uten å være innom sykehuset. Erfaringene fra Røros viser at modellen forutsetter vilje til å jobbe på tvers av profesjoner og forvaltningsnivåer. Per Ivar Lundli fra Røros helsevakt påpeker at det er pasienten som vinner når helsepersonell samarbeider på tvers av faggrenser og forvaltningsnivåer (Hofstad 2021).

6.2.3 Trygg overgang

Trygg overgang er en strukturert overgangsordning som gjelder for alle pasienter som henvises til, eller skrives ut fra hjemmesykehus. Ordningen har som hensikt å gjøre overgangsfaser tryggere og mer forutsigbare for alle involverte, og er todelt.

Den første komponenten omfatter aktiv vurdering og tilrettelegging før hjemmebehandling starter. Når en pasient henvises til hjemmesykehus, enten fra fastlege, legevakt, ambulanse, helsevakt, eller direkte fra St.Olavs, gjør helsevakten og hjemmesykehus-sentralen en felles vurdering av om pasienten kan behandles trygt hjemme. Dette innebærer kartlegging av funksjonsnivå, sosiale og praktiske forhold hjemme, pårørendes kapasitet og pasientens forutsetninger for å bruke teknologi. Der det er behov bistår de i opplæring og tilpasning i oppstartfasen av behandlingen. Varigheten av trygg overgang til hjemmesykehus er ikke forhåndsbestemt, men heller tilpasset den enkelte pasient sine behov. På den måten kan ordningen både imøtekomme de som kun har behov for ett besøk, og de som har behov for en lengre overgangsperiode.

Den andre komponenten er 72 timers åpen telefon, inspirert av Kongsberg kommunes prosjekt (Kongsberg kommune 2026; Kristoffersen 2026). Etter utskrivelse, enten fra sykehus eller hjemmesykehus, har kommunehelsetjenesten og den utskrevne pasienten mulighet til å henvende seg til St.Olavs med eventuelle spørsmål eller bekymringer. Liknende tiltak i Danmark har vist en reduksjon i reinnleggelse fra 22 til 17 prosent (Kongsberg kommune 2026).

Til sammen utgjør dette en ordning rundt overganger som er tilpasset pasientens faktiske situasjon og evner. Dette vil være et viktig skritt mot en mer helhetlig helsetjeneste, og legge et viktig grunnlag for god samhandling mellom kommune og sykehus.

6.2.4 Skjemabasert vurdering

En forutsetning for trygg behandling hjemme er at vurderingen av pasientens egnethet skjer systematisk, med faste kriterier som grunnlaget for vurderingen. Erfaringen fra Samnanger viser at systematisk bruk av sjekklister gjør overgangen tryggere, reduserer behovet for korttidsplasser og gjør praksis mindre personavhengig (KS n.d.).

Et tilsvarende verktøy vil være sentralt i hjemmesykehusmodellen ved St. Olavs. Helsevakten og hjemmesykehus-sentralen vil bruke strukturert, skjemabasert kartlegging i vurderingen av alle pasienter som henvises til hjemmebehandling. Denne systematiseringen av vurderinger som allerede gjøres vil bidra til at tjenesten blir enklere å koordinere og skalere.

6.2.5 Teknologistøttet hjemmebehandling

Teknologistøttet hjemmebehandling er viktig for å ha muligheten til å flytte avansert behandling ut av sykehuset. Det kreves dermed en helhetlig satsning på teknologi som aktiv behandlingsstøtte og som verktøy for diagnostikk i felt. Behandlingsstøtte omfatter teknologi som for eksempel IV-pumper eller digital fjernstyring med hodekamera (G. Karlsen 2026; L. Karlsen 2026). Diagnostikk i felt handler om å gi helsepersonell verktøy til å ta gode, faglige beslutninger uten at pasienten må inn til sykehuset. Dette kan omfatte teknologi for å gjennomføre analyse av blodprøver, ta blodgass, eller til og med røntgen. Begge aspektene er nødvendig for at hjemmesykehus skal fungere som en reell behandlingsarena.

Pasienter som er i hjemmesykehus ivaretas av hjemmesykehussentralen. Ikke alle pasienter har samme forutsetninger for å bruke teknologi. Behandlingsforløpene tilpasses etter teknologiske ferdigheter og behov for fysiske besøk. Spennet i pasienter vil dermed kunne variere fra pasienter som mestrer behandling støttet av teknologi på egen hånd eller ved hjelp av pårørende, til de som behøver omfattende behandling med fysisk tilstedeværelse av helsepersonell der teknologi fungerer som støtte.

Helse Midt-Norge har allerede Helseplattformen som felles digital infrastruktur. Det er et godt utgangspunkt, men hjemmesykehusmodellen krever målrettet utvikling av plattformen. Samtidig er en koordinert tilnærming til teknologianskaffelse nødvendig for å unngå videre fragmentering.

6.3 Tjenesten som helhet

De foregående delene har beskrevet tjenestens komponenter hver for seg, men komponentene fungerer i praksis som ett sammenhengende system, der hver del løser en spesifikk utfordring i forløpet. Når en pasient er i kontakt med primær- eller spesialisthelsetjenesten, vurderer helsevakten eller hjemmesykehus-sentralen om hjemmebehandling er mulig. Hvis pasienten er egnet, overtar sentralen koordineringsansvaret og starter trygg overgang: helsevakten eller hjemmesykehus-sentralen gjør hjemmebesøk, kartlegger situasjonen og bistår i oppstart av behandling. Selve hjemmesykehusforløpet består av en kombinasjon av digital oppfølging og fysisk oppfølging fra hjemmesykepleie eller hjemmesykehus-sentralen. Når behandlingen avsluttes, starter 72 timer åpen telefon, som gir pasienten og kommunehelsetjenesten et faglig sikkerhetsnett i den mest sårbare fasen.

Det som binder systemet sammen er hjemmesykehus-sentralen. Den er til stede i alle faser, men rollen skifter mellom vurdering og koordinering, til overvåking og faglig støtte, og tilgjengelighet ved utskrivelse. Uten sentralen som fast koordineringspunkt ville de øvrige komponentene fungert som separate tiltak, ikke som ett system. Dette er illustrert i aktørkartet, se figur 11. Grønne aktører representerer primærhelsetjenesten, blå representerer spesialisthelsetjenesten, og pasienten og pårørende er skilt ut som egne kategorier.

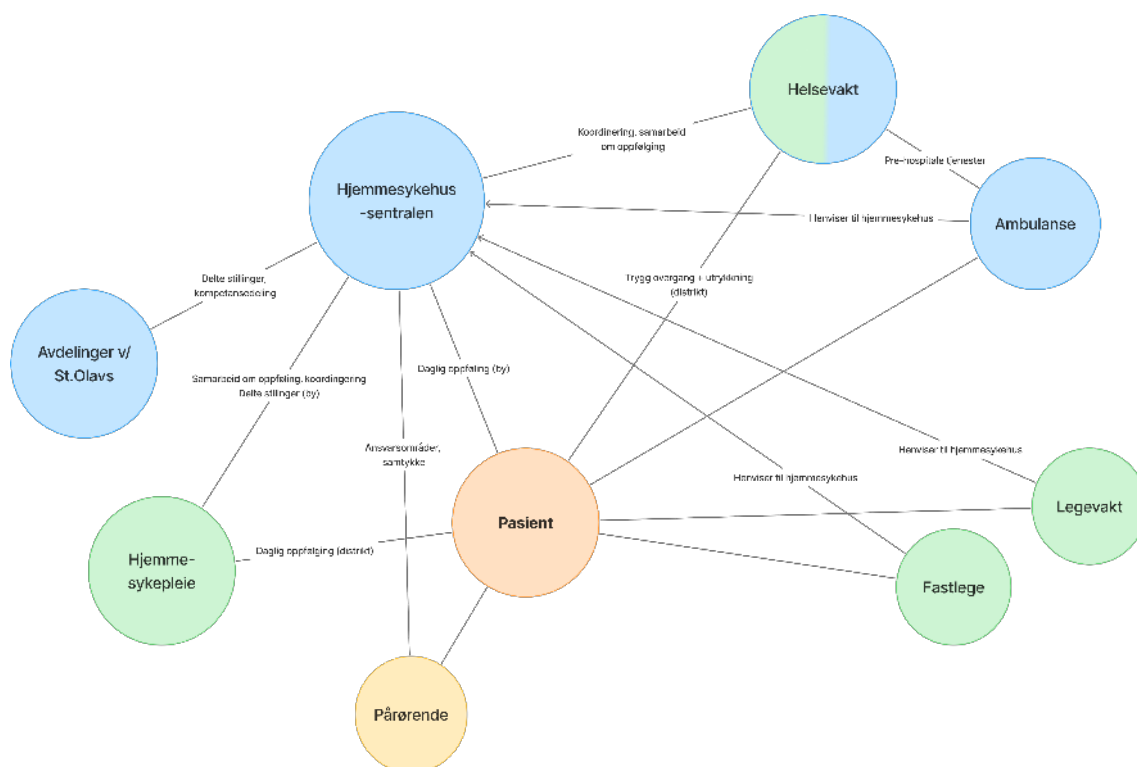


Figure 11: Aktørkart

Tjenestekartet viser tjenestens fulle forløp fra første kontakt til avsluttet behandling. Det mest sentrale å se etter er koordineringsansvaret hos hjemmesykehus-sentralen som er til stede i alle faser, men rollen skifter fra aktiv vurdering i starten til overvåking og faglig støtte underveis. Overgangspunktene mellom aktørene, særlig ved oppstart av hjemmebehandling og ved utskrivelse, er der koordineringsbehovet er størst.

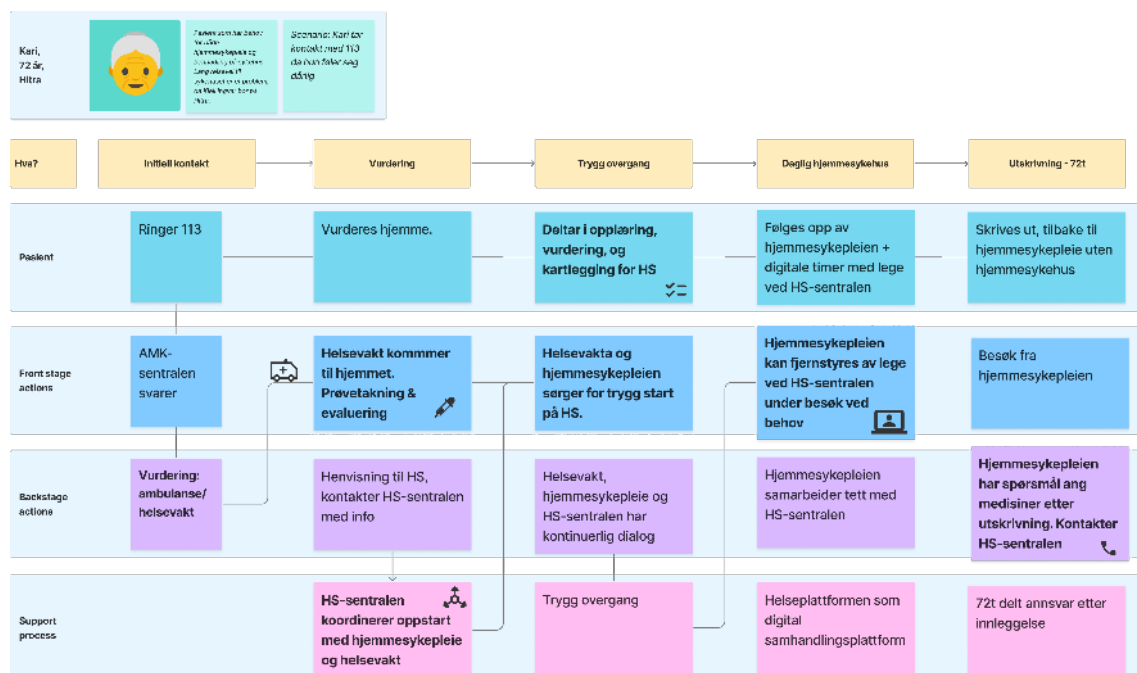


Figure 12: Service blueprint illustrerer tjenesten

Tjenestekonseptet som er beskrevet i dette kapittelet er et forslag til hvordan hjemmesykehus kan organiseres. Det er utviklet med utgangspunkt i elementer som allerede har vist seg å fungere godt i norsk helsetjeneste, satt sammen til et større system. Denne måten å angripe hjemmesykehus på, forutsetter at det bygges strukturer som gjøre systemet lite avhengig av enkeltpersoner som bærer store deler av innsatsen. Forutsetninger og implikasjoner av dette behandles i neste kapittel.

7 Refleksjoner

Dette kapittelet presenterer refleksjoner vi har gjort oss i utarbeidelsen av strategien for hjemmesykehus ved St. Olavs Hospital. Refleksjonene tar opp forhold vi mener er viktige å være bevisst på når man jobber med hjemmesykehus, både på strategisk og operasjonelt nivå. Noen av disse forholdene ligger innenfor det St. Olavs kan påvirke direkte, mens andre krever endringer på nasjonalt nivå eller samarbeid med eksterne aktører.

7.1 Hjemmesykehus som trend

Hjemmesykehus befinner seg i en tidlig fase i Norge. Den første nasjonale landskonferansen ble gjennomført i 2026, som understreker at dette er et relativt ungt felt i Norge. Samtidig har de siste årene blitt utviklet flere prosjekter med hjemmesykehus, og medieoppslag viser positive erfaringer fra pasienter som har blitt behandlet på hjemmesykehus fremfor langvarig innleggelse på sykehuset (NRK 2025).

7.1.1 Hvorfor trendbygging er viktig

For at hjemmesykehus skal utvikles fra enkeltinitiativer til etablert praksis, kreves det en bredere bevegelse der flere aktører bidrar samtidig. Fire forhold må være til stede:

Politisk agenda: Regelverket er en betydelig barriere for skalering. En stigende trend øker sannsynligheten for at hjemmesykehus adresseres politisk og juridisk. Når flere sykehus og kommuner etterspør endringer i ISF-regelverket, blir det vanskeligere for nasjonale myndigheter å avvise behovet.

Etterspørsel fra pasienter: Pasientvelferd er en viktig driver i helsetjenesteutvikling. Kjennskap til hjemmesykehus som alternativ til innleggelse kan over tid skape etterspørsel som helsetjenesten må forholde seg til. Når pasienter vet at behandling hjemme er mulig, vil de i større grad etterspørre det.

Faglig kunnskapsgrunnlag: Systematisk dokumentasjon av erfaringer bidrar til å etablere feltet faglig. Et sterkere kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for regelverksendring og nasjonal standardisering. Uten dokumenterte effekter og erfaringer forblir hjemmesykehus et eksperiment fremfor en etablert praksis.

Institusjonell posisjon: Et sykehus som aktivt bidrar til å forme feltet får større innflytelse over hvordan nasjonale løsninger utformes, fremfor å tilpasse seg standarder satt av andre. Å være med tidlig gir mulighet til å påvirke retningen feltet tar.

7.1.2 St.Olavs bidrag til trendbygging

St. Olavs befinner seg i en unik posisjon til å bidra aktivt til at hjemmesykehus blir en etablert praksis. Som universitetssykehus samarbeider St. Olavs tett med NTNU om utdanning og forskning, og er omtalt som Norges ledende sykehus innen innovasjon og tjenesteutvikling. Tjenesteinnovasjonssenteret (TIPS) ved St. Olavs er allerede i gang med en mer omfattende utredning av hvordan hjemmesykehus skal organiseres ved sykehuset, noe som viser at arbeidet er godt i gang. For å styrke posisjonen som pådriver for hjemmesykehus på nasjonalt nivå, kan St. Olavs vurdere følgende tiltak:

Styrke samarbeidet med NTNU: Gjennom å initiere forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU og evaluere erfaringer fra eksisterende hjemmesykehustilbud, kan St. Olavs bidra til å bygge det faglige kunnskapsgrunnlaget. Publisering av resultater i akademiske tidsskrifter gjør erfaringene tilgjengelige for andre aktører, mens presentasjoner på konferanser gir mulighet til direkte erfaringsutveksling. Sammen styrker dette argumentasjonen overfor beslutningstakere ved å dokumentere at hjemmesykehus fungerer i praksis.

Spre pasienthistorier: Konkrete erfaringer fra pasienter som har mottatt behandling hjemme synliggjør effekten av hjemmesykehus på en måte som tall ikke klarer alene. Dette kan øke etterspørselen fra pasienter og styrke det politiske grunnlaget for endring.

Delta i nasjonale og internasjonale konferanser: Ved å posisjonere St. Olavs som aktiv bidragsyter nasjonalt og internasjonalt, styrkes sykehusets institusjonelle posisjon. Det gir også tilgang til erfaringer fra andre aktører og mulighet til å påvirke utviklingen av feltet.

Etablere fagnettverk med norske sykehus: Strukturert erfaringsdeling på tvers av sykehus unngår at løsninger forblir isolerte enkeltprosjekter. Et nettverk av sykehus som jobber med hjemmesykehus kan også fremstå som en sterkere stemme overfor nasjonale myndigheter enn enkeltstående aktører.

Samarbeide med pasientorganisasjoner: Når pasientorganisasjoner løfter frem positive erfaringer med hjemmesykehus, får budskapet legitimitet utover det St. Olavs kan oppnå alene. Dette styrker argumentasjonen ved at etterspørselen etter hjemmesykehus fremstår som pasient-drevet, ikke bare sykehusdrevet.

Invitere beslutningstakere: Å gi politikere og helsebyråkrater direkte innsikt i hvordan hjemmesykehus fungerer i praksis kan overbevise dem om nødvendigheten av systemendringer. Når beslutningstakere møter pasienter som mottar behandling hjemme og observerer hvordan tjenesten faktisk leveres, blir både effekten og behovet for systemendringer konkret og håndgripelig. Det er lettere å prioritere hjemmesykehus når man har sett en pasient motta trygg behandling i eget hjem, fremfor kun å forholde seg til rapporter og tall. Gjennomarbeidede strukturer for disse møtene slik at gode effekter synliggjøres, kan være et viktig tiltak for å øke påvirkning.

St. Olavs kan vente og tilpasse seg modeller utviklet av andre når feltet modnes, eller ta en aktiv rolle nå og bidra til å forme hvordan hjemmesykehus organiseres i Norge. Ved å engasjere seg tidlig, før strukturene er satt, får sykehuset bedre mulighet til å påvirke utviklingen av feltet.

7.2 Flaskehalser

Selv om strategien adresserer kapasitetsutfordringer i sykehuset, risikerer den å skape nye problemer andre steder i systemet dersom den ikke implementeres bevisst. Tre områder er særlig kritiske.

7.2.1 Overbelastning av hjemmesykepleien

I likhet med andre helsetjenester som er omtalt i kapittel 5.1, preges hjemmetjenesten av høy arbeidsbelastning og utfordringer med bemanning (Hestvik 2026; Norsk Sykepleierforbund n.d.). Nasjonale analyser peker på at personellmangel vil være en av de største begrensingene for fremtidens helsetjeneste (Helsepersonellkommissjonen 2023). For at hjemmesykehus skal være gjennomførbart, må hjemmesykepleien fritas fra andre oppgaver når de påtar seg ansvar for hjemmesykehuspasienter. Nye oppgaver kan ikke bare legges oppå en allerede høy arbeidsbelastning; den totale belastningen må holdes relativt stabil.

Dette kan oppnås gjennom:

- Mer presis seleksjon av pasienter som faktisk krever fysisk oppfølging
- Økt bruk av teknologiske løsninger som reduserer behovet for hjemmebesøk
- Målrettet bruk av spesialistkompetanse der den faktisk trengs

Erfaringer fra digitale samhandlingsløsninger, som SamSår, viser at dette kan frigjøre kapasitet ved å redusere reisetid for helsepersonell (Helse Sør-Øst RHF 2026). Uten tilstrekkelig avlastning vil hjemmesykehus i praksis forsterke kapasitetsproblemet i kommunehelsetjenestene ved å legge flere oppgaver til en allerede presset tjeneste. Med reell avlastning kan hjemmesykepleien utvikles til en mer integrert og faglig styrket del av behandlingsskjeden, samtidig som samlet ressursutnyttelse

forbedres. Dette samsvarer med et grunnleggende prinsipp i helsepolitikken om at gevinster må hentes ut gjennom bedre organisering, ikke gjennom økt arbeidsmengde. (Regjeringen 2024a; Vestre 2026).

7.2.2 Belastning på pårørende

Som beskrevet i kapittel 3.6, er pårørende allerede en sentral ressurs i norsk helsevesen, med en innsats verdt 63,4 milliarder kroner årlig (Pedersen et al. 2025). Uten tydelig avklaring og ansvarsfordeling risikerer man å overføre belastningen fra helsevesenet til pårørende (Terjesen 2026).

Strategien adresserer dette gjennom trygg overgang, der dialog med pårørende er en sentral del av kartleggingen. I denne fasen skal forventninger avklares, ansvar fordeles og pårørendes kapasitet vurderes. Dersom pårørende skal utføre behandlingsoppgaver som normalt ville vært utført av helsepersonell, må det være på plass systemer for regelmessig rapportering og vurdering av belastning. Dette kan eksempelvis skje gjennom digitale skjemaer der pårørende rapporterer tidsbruk og opplevelse av arbeidsbyrde, eventuelt supplert med bilder av utførte oppgaver, som for eksempel sårstell.

Den potensielle økte arbeidsbelastningen på pårørende belyser behovet for at nasjonale myndigheter adresserer økonomisk kompensasjon som en del av rammeverket for hjemmesykehus.

7.2.3 Fragmentert teknologi

Utfordringen med fragmentert teknologi er ikke unik for helsesektoren. Innen maritim industri opplevde man tilsvarende utfordringer med systemer fra ulike leverandører. Denne fragmenteringen bidro ikke bare til at man må lære og forholde seg til mange systemer, men man blir også mindre rustet til å ta gode beslutninger i kritiske situasjoner.

Et tiltak som har hatt god, samlet effekt i den maritime sektoren er utviklingen av OpenBridge, et åpen kildekode designsystem som sakte men sikkert har blitt bransjestandard. OpenBridge løste problemet ved å standardisere brukergrensesnitt og interaksjonsmønstre på tvers av ulike leverandører, slik at navigatører møter gjenkjennbare løsninger uavhengig av hvilken produsent som leverer utstyret (Nordby 2026).

En tilsvarende tilnærming for medisinsk utstyr i hjemmebehandling kunne adressert fragmenteringsproblemet på et strukturelt nivå. I dag utvikles teknologien i stor grad isolert. I forbindelse med SamSår-prosjektet utviklet de en egen utstyrs koffert for sårbehandling. Under implementering oppdaget de imidlertid at hjemmesykepleien allerede opererte med seks ulike koffertter med medisinsk utstyr (Sørli 2026). Sammensetningen av parallelle løsninger blir dermed en stor barriere for at hjemmebehandling skal fungere godt.

St. Olavs bør være en pådriver for utvikling av felles standarder for medisinsk teknologi i hjemmebehandling. Dette innebærer ikke nødvendigvis å utvikle teknologien selv, men å stille krav til leverandører om interoperabilitet og å samarbeide med andre sykehus og Helseplattformen om felles designprinsipper.

7.3 Potensielle gevinster og begrensninger

7.3.1 Hva strategien kan oppnå

St. Olavs gjør behandling i hjemmet til et reelt alternativ i både by og distrikt. En modell som kombinerer å unngå innleggelse og tidlig utskrivning legger til rette for forsvarlig og ressursbesparende behandling.

Strategien kan:

-
- Redusere unødvendige innleggelser og forkorte liggetid
 - Gi bedre pasientopplevelse gjennom raskere restituering, mindre smitterisiko og mer normal hverdag
 - Bygge kompetanse i både sykehus og kommuner gjennom systematisk samarbeid og kompetansedeling
 - Være mer bærekraftig enn å bygge ut sykehuskapasitet for å møte eldrebølgen

For pasienter viser forskning at behandling hjemme gir raskere restituering og redusert antall reinnleggelser. (Cheng et al. 2025; He et al. 2026). Hjemmebehandling reduserer smitterisiko, gir mindre fokus på sykdom og mer på restituering, og tillater mer tid sammen med familie. Dette gjelder særlig i palliative forløp, der nærhet og trygghet har stor betydning.

For helsepersonell kan delte stillinger mellom hjemmesykepleie og sykehus gjøre hjemmesykepleie mer faglig attraktiv, noe som er særlig viktig i en tid der rekruttering er krevende. Systematisk kompetansedeling mellom sykehus og kommune vil heve kompetansenivået hos begge parter.

For kapasitet viser erfaringer fra Kongsberg at 72 timers oppfølging etter utskrivelse kan forebygge reinnleggelser (Kongsberg kommune 2026; Kristoffersen 2026). Helsevaktmodellen fra Røros dokumenterer at raskere og mer fleksibel respons i distriktene frigjør ambulansekapasitet (Hofstad 2021).

7.3.2 Hva strategien ikke løser alene

Strategien er ett grep av flere, og løser ikke kapasitetsutfordringen alene. Den eliminerer ikke behovet for flere helsepersonell, men utnytter eksisterende kapasitet bedre. Den fjerner ikke geografiske ulikheter i tilbud, men reduserer dem betydelig.

Full effekt forutsetter endringer i nasjonale rammebetingelser for finansiering og lovverk, noe St. Olavs kan påvirke gjennom dokumentasjon og dialog, men ikke kontrollerer. Strategien krever også omstilling fra etablerte arbeidsformer og nye ferdigheter på digital oppfølging. Som beskrevet i kapittel 2.4, er endring krevende i en organisasjon preget av hierarki og inngrodde rutiner. Endring må derfor forankres både i ledelsen og blant de ansatte som faktisk skal bruke de nye løsningene i praksis.

8 Konklusjon

St. Olavs har kompetansen og den politiske støtten som trengs for hjemmesykehus. Det som gjenstår er å bygge strukturene som gjør at tjenesten kan skaleres og drives uten å hvile på enkeltpersoner.

Strategien som anbefales kombinerer å unngå innleggelse og tidlig utskrivelse som ett helhetlig system, der en hjemmesykehus-sentral ved St. Olavs har koordineringsansvaret gjennom hele forløpet. Grunnlaget er å flytte kompetansen nærmere pasienten der det er forsvarlig å gjøre det. Det krever ulik organisering i by og distrikt, og tydelig ansvarsfordeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

For at strategien skal fungere, må organisatorisk forankring, teknologisk infrastruktur og endring i ISF-regelverket adresseres parallelt. Den fasevise implementeringsplanen er utformet slik at St. Olavs kan opparbeide erfaring og dokumentasjon underveis. På den måten styrkes grunnlaget for å være en aktiv fremdriver av hjemmesykehus. Med de riktige strukturene på plass har hjemmesykehus potensial til å frigjøre kapasitet og ressurser, styrke samhandling, og gi pasienter et reelt alternativ til sykehusopphold, også utenfor Trondheim by.

Referanser

- Barstad, Anders and Roger Hammersland (2025). *Eldrebefolkningen, nå og i framtiden*. URL: <https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/artikler/eldrebefolkningen-na-og-i-framtiden> (visited on 4th May 2026).
- Cheng, Mengyuan et al. (2025). 'Effectiveness of admission-avoidance hospital at home as alternative to routine hospital care in older adults: a systematic review and meta-analysis'. In: *Global Transitions* 7, pp. 342–349. ISSN: 2589-7918. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.glt.2025.06.002>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589791825000258>.
- Dahlen, Kristin (Apr. 2026). 'Finansieringsordninger for hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging'. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- Danielsen, Else Margrethe and Sturla Gjesdal Fjær (2020). 'Reell samhandling forebygger reinnleggelse'. In: *Tidsskrift for Den norske legeforening* 140.1. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0787. URL: <https://tidsskriftet.no/2020/01/leder/reell-samhandling-forebygger-reinnleggelse>.
- Elkjær, Mette (Apr. 2026). 'Mapping Scandinavian Hospital-at-Home Organisations and Interventions for Patients with Acute Somatic Illness'. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- Guðnadóttir, Guðný Stella (Apr. 2026). 'Nøkkelfaktorer i ruralt hjemmesykehus'. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 22. april. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- He, Hongyao et al. (May 2026). *Efficacy and Safety of Hospital-at-Home versus Traditional Hospital Care in Older Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials*. Tech. rep. Review: kortere liggetid.
- Helse Sør-Øst (n.d.). *Spredning av digitale sårtjenester: SamSår-prosjektet*. Tech. rep. Helse Sør-Øst. URL: <https://www.helse-sorost.no/samsar> (visited on 11th May 2026).
- Helse Sør-Øst RHF (2026). *Prosjektrapport SamSår: Spredning av digitale sårtjenester*. Prosjektrapport. Helse Sør-Øst RHF. URL: <https://www.helse-sorost.no/498eed/contentassets/6920df98b4194a209ea196108d9bdea8/sluttrapport-samsar.pdf> (visited on 8th May 2026).
- Helse- og omsorgsdepartementet (2024). *Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Vår felles helsetjeneste*. Meld. St. 9 (2023–2024). Helse- og omsorgsdepartementet. URL: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20232024/id3027594/> (visited on 13th May 2026).
- Helsedirektoratet (2020). *Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet-en mobil integrert helsetjenester*. Rapport. NTNU, Samfunnsforskning. URL: <https://samforsk.no/uploads/files/Kvalitativ-evaluering-av-Rorosprosjektet-WEB.pdf> (visited on 12th May 2026).
- (2021a). *Evaluering og vurdering av avansert hjemmesykehus for barn*. Tech. rep. Helsedirektoratet. URL: <https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluering-og-vurdering-av-avansert-hjemmesykehus-for-barn/innledning/historikk> (visited on 4th May 2026).
- (2021b). *Utredning av ønsket innretning av utskrivningsprosessen: Vurderinger og anbefalinger*. Rapport IS-3014. Helsedirektoratet. URL: <https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-onsket-innretning-av-utskrivningsprosessen/Utredning%20av%20%C3%B8nsket%20innretning%20av%20utskrivningsprosessen.pdf> (visited on 11th May 2026).
- (2025a). *Årsrapport Kompetanseløft 2025 – utviklingstrekk og status 2024*. Tech. rep. Helsedirektoratet. URL: <https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/arsrapport-kompetanseloft-2025-utviklingstrekk-og-status-2024/innsatsomrader-for-baerekraftige-helse-og-omsorgstjenester-copy-2/rekruttering-og-utvikling-i-arsverk> (visited on 4th May 2026).
- (Dec. 2025b). *Regelverk for innsatsstyrt finansiering 2026 (ISF-regelverket)*. Regelverk. Besøkt 6. mai 2026. Helsedirektoratet. URL: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd-og-finansiering/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-isf/isf-filer/isf-regelverk-2026.pdf/_/attachment/inline/28e68095-70c3-4ee0-828e-72019d83d4a1:e35c1068b05919094c3a1ccb984f12412dfb48fc/ISF-regelverk%202026.pdf.
- Helsepersonellkommisjonen (2023). *Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste*. Norges offentlige utredninger NOU 2023:4. Helse- og omsorgsdepartementet. URL: <https://www.helse-midt.no/48e7ec/siteassets/documents/2025/helsekommisjon-tid-for-handling.pdf> (visited on 13th May 2026).

-
- Hestvik, Ingebjørg (2026). *Tøft å være sykepleier: Høy arbeidsbelastning og lav bemanning*. URL: <https://www.sintef.no/siste-nytt/2026/toft-a-vare-sykepleier-hoy-arbeidsbelastning-og-lav-bemanning/> (visited on 4th May 2026).
- Hofstad, Eivor (2021). *Nye oppgaver for ambulansepersonellet*. URL: <https://sykepleien.no/2021/10/nye-oppgaver-ambulansepersonellet> (visited on 7th May 2026).
- Karlsen, Gudrun (Apr. 2026). 'Digital oppfølging med hodekamera - et samarbeid mellom poliklinikk, Pasientsentrert helsetjeneste-team (PSHT) og kommunehelsetjeneste'. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- Karlsen, Lillian (Apr. 2026). 'Hjemmesykehus for voksne - en kvalitativ studie av implementering og tjenestelevering av hjemmesykehus i en norsk helsetjenestekontekst'. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- Kongsberg kommune (2026). *Nytt prosjekt gir økt trygghet etter innleggelser*. Sist oppdatert 6. februar 2026, besøkt 11. mai 2026. Kongsberg kommune. URL: <https://www.kongsberg.kommune.no/nytt-prosjekt-gir-oekt-trygghet-etter-innleggelser>.
- Kristoffersen, Stian (Apr. 2026). '72-timers oppfølging etter utskrivelse – et steg mot integrert hjemmesykehus? Erfaringer fra Prosjekt X - Samhandlingsarena Kongsberg'. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april [Paperpresentasjon]. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- KS (n.d.). *Bedre struktur når pasienten kommer hjem fra sykehuset*. URL: <https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/gode-pasientforlop/artikler/bedre-struktur-nar-pasienten-kommer-hjem-fra-sykehuset/> (visited on 11th May 2026).
- Moland, Leif E., Åge A. Tiltnes and Anne Merete Bjørnerud (2026). *Helsefelleskapenes rekrutterings- og samhandlingstilskudd: Fordelings- og styringsutfordringer i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak*. Tech. rep. Fafo. URL: <https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsereform/ny-rapport-rekrutterings-og-samhandlingstilskuddet-styrker-samhandlingen-mellom-sykehus-og-kommuner/> (visited on 11th May 2026).
- Nordby, Kjetil (Jan. 2026). 'Gjesteforelesning om OpenBridge designsystem'. In: *OpenBridge* (Institutt for design). 26. januar.
- Norsk Sykepleierforbund (n.d.). *Fakta om sykepleiernes arbeidsmiljø*. URL: <https://www.nsf.no/arbeidsvilkar/fakta-om-sykepleiernes-arbeidsmiljo/> (visited on 4th May 2026).
- NRK (2025). *Lillehammer lykkast i å gjøre det bedre for eldre*. URL: <https://www.nrk.no/innlandet/lillehammer-lykkast-i-a-gjore-det-betre-for-eldre-1.17852114> (visited on 6th May 2026).
- Pedersen, Simen et al. (2025). *Samfunnsøkonomiske kostnader av pårørendeinnsett i Norge*. Tech. rep. 64/2025. Menon Economics. URL: <https://menon.no/uploads/images/Samfunnsregnskap-for-p%C3%A5r%C3%B8rendeinnsett-i-Norge.pdf> (visited on 11th May 2026).
- Regjeringen (2023). *Finansiering av kommunesektoren*. URL: <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/finansiering-av-kommunesektoren/finansiering-av-sektoren-samlet-herunder/id552048/> (visited on 11th May 2026).
- (2024a). *Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste*. Tech. rep. Regjeringen. URL: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan-2024-2027-kortere-ventetider-og-en-felles-helsetjeneste/id3028011/?expand=factbox3028049> (visited on 4th May 2026).
- (2024b). *Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd for helsetjenesten*. Rapport. Regjeringen, Helse- og omsorgsdepartementet. URL: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-rekrutterings-og-samhandlingstilskudd-for-helsetjenesten/id3048046/>.
- Rijal, Sujana et al. (2026). 'Providing effective and efficient hospital admission avoidance inpatient care: a systematic realist review of Norwegian municipal inpatient acute care services'. In: *BMC Health Services Research* 26.1. Open access, unedited version. Published online 29 April 2026, Article number not yet assigned. DOI: 10.1186/s12913-026-14621-z. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-026-14621-z>.
- Rohde, Tarald et al. (Oct. 2015). *Evalueringsprosessen i Helse Sør-Øst*. Rapport. SINTEF. URL: <https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/sintef-a26795-rapport-entelig-260315-2.pdf>.
- Severinsen, Jan Eskil (2026). *Deler ut nye millioner i samhandlingsmidler*. URL: <https://www.helsenord.no/nyheter/2026/tildelte-nye-millioener-i-samhandlingsmidler/> (visited on 13th May 2026).
-

-
- Sørli, Hilde (Apr. 2026). ‘SamSår – bedre sårbehandling gjennom digital samhandling hjemme hos pasienten’. In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- St. Olavs hospital (2025). *Hjemmesykehus: Ny samarbeidsmodell mellom sykehus og kommune*. Intern presentasjon, ikke publisert.
- Strand, Bjørn Heine et al. (2023). *Folkehelse rapporten: Helse hos eldre i Norge*. URL: <https://www.fhi.no/he/fr/folkehelse rapporten/grupper/eldre/#eldre-i-befolkningen> (visited on 4th May 2026).
- Terjesen, Anne-Grethe (Apr. 2026). ‘Hva kreves av systemet når pårørende får en aktiv rolle i hjemmesykehus?’ In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 22. april [Paperpresentasjon]. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.
- Vestre, Jan Christian (2026). *Helsetalen 2026*. URL: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helsetalen-2026/id3146275/> (visited on 4th May 2026).
- Vestre Viken HF (2023). *Kunstig intelligens i bildediagnostikk*. Accessed: 2026-05-11. Vestre Viken HF. URL: <https://www.vestreviken.no/fag-og-forskning/bildediagnostikk/kunstig-intelligens/>.
- (2024). *Mobil røntgen*. Sist oppdatert 30. august 2024, besøkt 11. mai 2026. Vestre Viken HF. URL: <https://www.vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/mobil-rontgen>.
- Vitalthings (n.d.). *Vitalthings Guardian H10*. Tech. rep. Vitalthings. URL: <https://s48869.p701.sites.pressdns.com/produkter/vitalthings-guardian-h10/> (visited on 11th May 2026).
- Wahl, Ranja S. and Kristine Holbø (Apr. 2026). ‘Mot hjemmesykehus som felles tjeneste – hvor starter vi?’ In: *Hjemmesykehus Landskonferansen* (Kristiansund). 23. april [Paperpresentasjon]. URL: <https://www.hjemmesykehuskonferansen.no/program-2026>.

Vedlegg

A Intervju 1: Avansert hjemmesykehus (AHS)

Informant	Sykepleier og leder, AHS
Dato	9. februar 2026, 09:00–10:00
Format	Digitalt, semistrukturert
Deltakere	3 gruppemedlemmer + 1 informant

Om AHS

AHS ble startet i Oslo og Bergen i 2017 og er i dag kun poliklinisk i Trondheim. Tilbudet har om lag 1 200 besøk årlig, med en jevn strøm av pasienter med stor variasjon i diagnosebildet. De største pasientgruppene er barn med kreft, nevrologiske tilstander og palliative behov. Kjøretid inntil én time fra sykehuset definerer nedslagsfeltet. Pasienter følges opp fra to ansatte, og noen følges over flere år.

Samarbeid

AHS lærer opp hjemmesykepleien i kommunene og opplever kommunen som svært positiv og tilgjengelig. Begrepet «samsone» var ikke kjent fra informantens ståsted.

Opplæring

Foreldre opplæres i utstyr og prosedyrer. Omfanget varierer avhengig av diagnose og familiesituasjon. Modellen er sykepleierstyrt, med én lege som har det siste ordet.

Hvem får tilbudet

Ungene er innlagt i 4–5 uker med dagspermisjon før de sendes hjem, slik at de kjenner ansiktet som møter dem hjemme. Tilbudet avslås sjelden, og de fleste ønsker hjemmesykehus igjen. Tilbakefall til sykehus er svært sjeldent.

Kritiske situasjoner og beredskap

AHS har aldri ringt 113. Ambulanse er tilkalt et par ganger, men uten alvorlige hendelser. Noe stikkskader forekommer, men dette beskrives som noe som skjer «overalt». Prinsippet er at ungene er på sykehuset når de *må* og hjemme når de *kan*. Ved sykefravær blant ansatte må pasientene i noen tilfeller komme til sykehuset. Pasientene informeres om dette på forhånd og aksepterer det som en del av tilbudet.

Overgang til voksentjenester

Når pasienten fyller 18 år gjennomføres et overføringsmøte, men AHS kan ikke tilby tilsvarende oppfølging i voksenhelsetjenesten.

Kapasitet og skalering

AHS har nådd et kapasitetstak og vurderer dagens driftsmodell som ikke bærekraftig på sikt. Sykefravær er det største operative problemet, ettersom teamet er svært lite. Pasientgrunnlaget vokser i takt med urbanisering. For å skalere er det avgjørende å ha ledelsen på klinikken med på laget og å rekruttere ildsjeler. Leger er ofte skeptiske til å «gi slipp» på pasienten.

Økonomi

Hjemmebehandling er rimeligere enn innleggelse: spart kostnad inkluderer nattevakter, senvakter, mat til barn og foreldre samt renhold av rom. Finansieringsmodellen oppleves som krevende, og det er behov for klarere rammer rundt ISF-fordeling mellom sykehus og kommune.

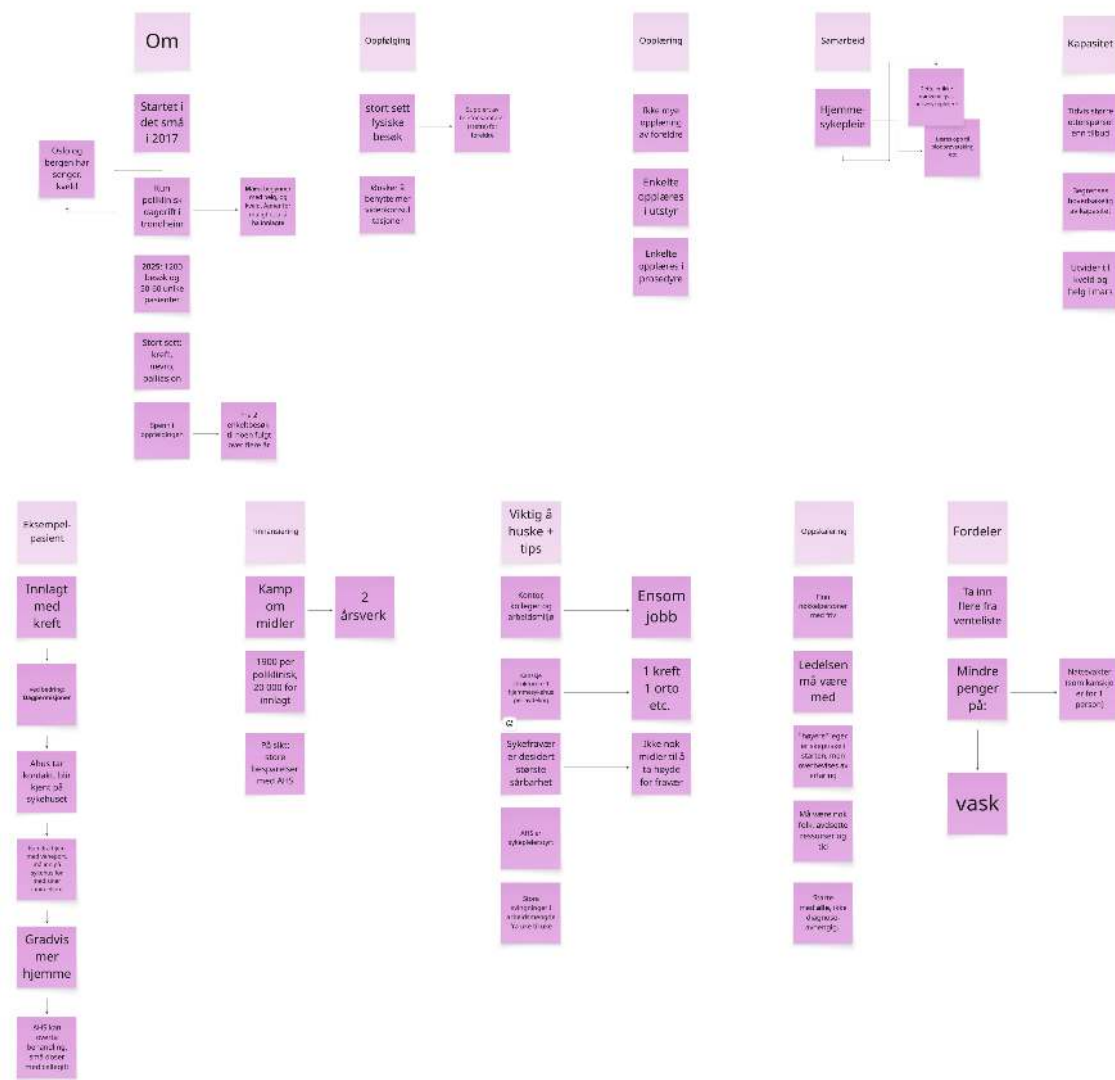


Figure 13: Post-it-lapper fra intervju med AHS

B Intervju 2: OUS Hjemme

Informant	Designer og innovasjonsrådgiver, OUS
Dato	9. februar 2026, 13:00–14:00
Format	Digitalt, semistrukturert
Deltakere	3 gruppe-medlemmer + 1 informant

Om OUS Hjemme

OUS Hjemme er en paraply som samler alle spesialisttjenester rettet mot hjemmebehandling. Målet er at 30 % av pasientene skal behandles hjemme innen 2030. Tjenesten er foreløpig ikke driftet i ordinære klinikker, og rammebetingelsene endrer seg kontinuerlig. Det er en klar forventning fra toppledelsen, men dette er ikke like tydelig kommunisert nedover i hierarkiet. Det er fortsatt uavklart hvor OUS Hjemme organisatorisk hører hjemme, og om det skal ligge i klinikk eller kommune.

OUS Hjemme dekker tre hovedspor:

- Avansert hjemmesykehus (AHS) for barn: tverrfaglig utreiseteam, døgkontinuerlig, diagnostikk-uavhengig tilbud som har vært i drift i om lag 10 år.
- Spesialiserte voksentilbud, for eksempel for pasienter etter stamcelletransplantasjon, som skrives ut til leilighet med dagbesøk.
- Digital oppfølging: om lag 4 000 aktive pasienter, sterkt knyttet opp mot samhandling med kommunen.

Ikke all hjemmebehandling kvalifiserer som hjemmesykehus. IV-antibiotika er for eksempel organisert poliklinisk og gir ikke samme finansielle grunnlag som en innleggelse.

Frivillighet

Det er i all hovedsak frivillig å delta i hjemmesykehustilbudet. Mange pårørende og pasienter ønsker å være hjemme. Psykiatrien håndterer dette godt på egenhånd.

Samarbeid mellom sykehus og kommune

OUS tar utgangspunkt i en modell der sykehuset har behandlingsansvaret mens kommunen er arbeidskraften. I Kristiansund har man fått til godt tverrkommunalt samarbeid, mens Oslo kommune beskrives som krevende å samarbeide med på tvers, blant annet på grunn av stor utskifting av ansatte i hjemmetjenesten.

OUS overleger skal i prinsippet være behandlere sammen med kommunene, men det finnes ingen finansiell ordning som understøtter dette. Når pasienter skrives ut, mister sykehuset inntekt, mens kommunen ikke kompenseres tilstrekkelig for oppfølgingsansvaret. OUS arbeider for å etablere en felles løsning med sykehusets og kommunens økonomiavdelinger.

Finansiering

Finansieringsmodellen er en av de største utfordringene. OUS Hjemme er et prosjekt uten dedikerte driftsmidler. Det er ikke etablert et nasjonalt rammeverk for finansiering av samhandlingstjenesten. I Danmark betaler sykehuset kommunen for oppfølging, noe OUS ser på som en mulig modell. Det er et uttalt ønske om å påvirke finansieringsordningen dersom utprøving med kommunene lykkes.

Største utfordringer

- Strategi og struktur: mangel på en overordnet nasjonal rigg.
- Finansiering av samhandlingstjenesten.
- Felles behovsforståelse på tvers av fagmiljøer.
- Mangelfullt datagrunnlag: det er ikke dokumentert at hjemmesykehus er samfunnsøkonomisk lønnsomt i norsk kontekst.

Skalering og bærekraft

Behovet for AHS for barn svinger, og tilbudet er sårbart: på nattevakt er det i perioder kun én sykepleier på vakt. Tjenesten er personavhengig og krever ildsjeler som tar initiativ og gjennomfører i klinikken. Et sentralt spørsmål er om man bør samle mer data før man skalerer, eller skalere for å samle erfaring og data.

C Intervju 3: Hjemmesykehus i Kristiansund

Informant	Sykepleier og forsker, Kristiansund kommune
Dato	16. februar 2026, 09:00–10:00
Format	Digitalt, semistrukturert
Deltakere	3 gruppedeltakere + 1 informant

Om informanten

Informanten er utdannet sykepleier med 16 års erfaring innen palliasjon og kreft. Hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund ble startet i 2017, og kartleggingen ble gjennomført i samarbeid med SINTEF. Informanten har siden tatt master og PhD relatert til hjemmesykehus.

Roller og forutsetninger

Det skilles mellom formelle hjelpere (sykepleiere og helsepersonell) og uformelle hjelpere (pårørende). Pårørende må være forberedt og trygge i rollen. For enkelte behandlinger, som IV-antibiotika, kreves tilgjengelige pårørende døgnet rundt. Hjemmesykehus generelt krever ikke nødvendigvis pårørende, men dette varierer med behandlingstype. Det er et uavklart spørsmål hvordan man skal legge til rette for pårørende som samarbeidspartnere, blant annet gjennom ordninger som omsorgslønn.

Pasientsikkerhet og oppfølging

Tidlig fase krever tett oppfølging. Det er viktig å vurdere pasientens helsekompetanse og evne til å følge råd, særlig når pasienten ikke er kjent fra før. Frivillighet er sentralt: pasienten må forstå hva de samtykker til. Behandlingsansvaret ligger hos helsepersonell, men pasienten bør involveres i beslutninger. Pasientene har mobil trygghetsalarm og kan komme i kontakt med helsepersonell raskt ved behov. Det finnes klare prosedyrer for når sykehuset skal kontaktes direkte og når veiledning er tilstrekkelig.

Frivillighet som prinsipp

I Kristiansund er hjemmesykehus basert på frivillig deltakelse. Press eller tvang kan føre til økt usikkerhet og flere reinnleggelser. Hjemmesykehus passer ikke for alle pasienter, og gode erfaringer for pasient, pårørende og behandlere er avgjørende for kvaliteten på tilbudet.

Samhandling mellom kommune og sykehus

Hjemmesykepleien kobles på i både urbane og rurale modeller. Geografiske avstander gir ulik tilgang til spesialistoppfølging. Fastlegens rolle kan være uklar, og det er flere gråsoner i behandlingsansvaret, særlig i distriktene der både fastlege og distriktslege skal være involvert. Lokale tilpasninger er nødvendige. I Kristiansund benyttes e-meldinger som dokumentasjonssystem, slik at informasjon ikke føres dobbelt mellom sykepleier og lege.

Internasjonale og nordiske modeller

Island har hatt rask utvikling gjennom stegvis oppbygging i små lokalsamfunn. Danmark praktiserer «admission avoidance», der behandling skjer hjemme for å unngå innleggelse. Norge følger

primært modellen «early discharge», der innleggelse etterfølges av overføring til hjemmesykehus. Et nordisk EU-prosjekt arbeider med digital opplæring i hjemmeoppfølging.

Finansiering

I Kristiansund er hjemmesykehuset organisert som en virtuell sengepost og finansieres som om pasienten er innlagt på sykehuspost. Dette gir en mer forutsigbar finansieringsmodell enn det som er tilfellet i mange andre regioner.

Barrierer for skalering

De viktigste barrierene på systemnivå er:

- Finansieringsmodell: kommunale og spesialisthelsetjenesten opererer med to adskilte systemer uten mekanismer som støtter kommunene. Det er behov for en nøytral finansieringsmodell.
- Dokumentasjon: det mangler et felles dokumentasjonssystem som fanger behovene til både sykepleiere og leger uten dobbeltføring.
- Samhandling: god koordinering mellom kommune og sykehus er en forutsetning for bærekraftig skalering.

D Intervju 4: Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Informanter	To representanter fra Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Dato	20. Februar 2026, 13:00–14:00
Format	Fysisk, IKT Brakka St. Olavs, ustrukturert
Deltakere	4 gruppemedlem + veileder fra St. Olavs + 2 informanter

Mulige pasientgrupper

- Antibiotikabehandling
 - Legges inn
 - Starter IV-antibiotika
 - Ser at behandlingen virker → Kan skrives ut til Øya helsehus eller til hjemmesykehus
 - NB! Pasientene er skjøre
 - Pasient ligger der i ca. en uke
 - Behandler parallelt, andre ting kan også oppstå
- Oppstart smertepumpe
 - Legges inn
 - Titreres, lindres → kan reise hjem
 - Får tabletter
 - Mulighet → justerer basert på dialog eller ved hjelp av hjemmesykepleie
- Livets slutfase
 - Krever mye helseressurser både fra sykehus og hjemmetjeneste
- Pasient det er usikkert om kan sendes hjem

Forutsetninger

- Trenger mer lege- og sykepleieressurser for å få dette til å gå rundt
- Hjemmesykehus kan ikke legges oppå uten også å få mer ressurser
- Pasient og pårørende får en pause ved sykehusinnleggelse. Dette må ivaretas.

Muligheter

- Hospitering → hjemmesykepleien er på besøk på St. Olavs og får breddekompetanse
- De som nå følges opp ambulant – hva med de som er bosatt utenfor Trondheim? Er de innlagt?
- Erfaring med delt stilling på St. Olavs og i hjemmesykepleien i Stjørdal

Utfordringer

- I dag kjenner vi ikke godt nok hjemmetjenesten. Kan de nok til å ta imot pasientene?
- Kompetanse
 - Hvordan få god nok erfaring i distriktene, f.eks. på Hitra
 - Gjennomføring er OK, men vurdering krever kompetanse
- Pasientene trenger mye støtte utover det somatiske

E Intervju 5: Trondheim kommune – e-helse og organisatoriske perspektiver

Informant	Rådgiver innen e-helse, Trondheim kommune
Dato	3. mars 2026, 10:00–11:00
Format	Fysisk, semistrukturert
Deltakere	2 gruppe-medlemmer + 1 informant

Om informanten

Informanten arbeider som rådgiver innen e-helse i Trondheim kommune, med innsikt i kommunale utviklingsprosjekter, digitalisering og organisatoriske prosesser i helse- og omsorgstjenestene. Informanten arbeider ikke direkte med hjemmesykehus, men bidro med perspektiver knyttet til kommunens kapasitet, endringsarbeid, implementering av nye løsninger og samhandling på systemnivå.

Møtefokus

Møtet tok utgangspunkt i et ønske om å forstå hvilke organisatoriske og strukturelle forhold som kan påvirke kommunens evne til å ta i bruk nye arbeidsformer og samarbeidsmodeller i helse- og omsorgstjenestene. Samtalen dreide seg derfor i stor grad om endringsarbeid, implementering, kapasitet og variasjoner mellom ulike deler av kommunen, heller enn konkrete løsninger for hjemmesykehus.

Informanten var generelt positiv til utvikling og nye løsninger i helsetjenestene, men beskrev samtidig at gjennomføring av større endringer i praksis ofte er krevende. Særlig ble belastningen i hjemmetjenestene og generell endringstretthet trukket frem som viktige utfordringer.

Kapasitet og belastning i kommunen

Et sentralt tema i møtet var kapasitetssituasjonen i hjemmetjenestene. Informanten beskrev en arbeidshverdag der mange tjenester allerede er presset på tid og ressurser, noe som gjør det utfordrende å innføre nye systemer, arbeidsformer eller kompetanseløp parallelt med ordinær drift.

Det ble diskutert hvordan nye initiativer i noen tilfeller kan oppleves som noe som kommer ovenfra, uten at det nødvendigvis er tydelig hvordan belastning, ansvar eller gevinster fordeles. Informanten beskrev at dette kan skape motstand eller skepsis, særlig dersom ansatte opplever at nye løsninger legges oppå eksisterende arbeid fremfor å erstatte eller forenkle noe som allerede gjøres.

Variasjon mellom enheter og lokal kultur

Informanten beskrev store forskjeller mellom ulike enheter og avdelinger i kommunen når det gjelder vilje og evne til å ta i bruk nye løsninger. Dette ble knyttet til både lokal kultur, ledelse og tidligere erfaringer med endringsprosesser.

Et eksempel som ble trukket frem var innføring av elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten. Enkelte avdelinger tok løsningen raskt i bruk, mens andre var mer tilbakeholdne og brukte betydelig lengre tid på implementering. Informanten opplevde at slike forskjeller i stor grad handler om lokale ledere og deres evne til å skape trygghet og eierskap rundt endringer.

Det ble også diskutert hvordan teknologisk modenhet ikke nødvendigvis handler om selve teknologien, men om kultur, trygghet og arbeidsmåter i de enkelte enhetene.

Endringsvilje og endringstretthet

Endringstretthet ble løftet frem som en gjennomgående utfordring. Informanten beskrev at ansatte i helse- og omsorgstjenestene over tid har stått i mange omstillingsprosesser, samtidig som arbeidshverdagen allerede er presset.

Det ble reflektert rundt hvordan implementering av nye løsninger derfor krever tydelig forankring, realistiske forventninger og god lokal ledelse. Informanten pekte også på at mange ledere i helse- og omsorgstjenestene primært har helsefaglig bakgrunn, men ikke nødvendigvis formell kompetanse innen endringsledelse eller organisasjonsutvikling.

Digital infrastruktur og samhandling

I løpet av møtet ble det gjennomført en enkel refleksjonsøvelse rundt kommunens opplevde modenhet innen områder som digital infrastruktur, samhandling, kompetanse og endringsvilje. Informanten vurderte kommunen som relativt sterk på digital utvikling og samhandling, men understreket samtidig at det fortsatt finnes utfordringer knyttet til integrasjon mellom systemer og ulik praksis mellom enheter.

Informanten beskrev også at det eksisterer mange overlappende begreper og initiativer innen digitalisering og helseutvikling, noe som kan skape uklarhet både organisatorisk og praktisk.

Viktige innsikter

Møtet tydeliggjorde særlig hvordan organisatoriske og menneskelige forhold kan være avgjørende for om nye løsninger lykkes i praksis. Informanten beskrev at utfordringene ofte handler mindre om selve teknologien, og mer om kapasitet, kultur, ledelse og evne til å gjennomføre endring i en presset organisasjon.

Videre pekte møtet på betydningen av:

- lokal forankring i de enkelte enhetene
- tydelig og realistisk implementeringstempo
- ledelse og trygghet i endringsprosesser
- forståelse for eksisterende belastning i tjenestene
- løsninger som fungerer innenfor dagens ressursituasjon
- bevissthet rundt språk, begreper og hvordan nye initiativer kommuniseres internt i kommunen

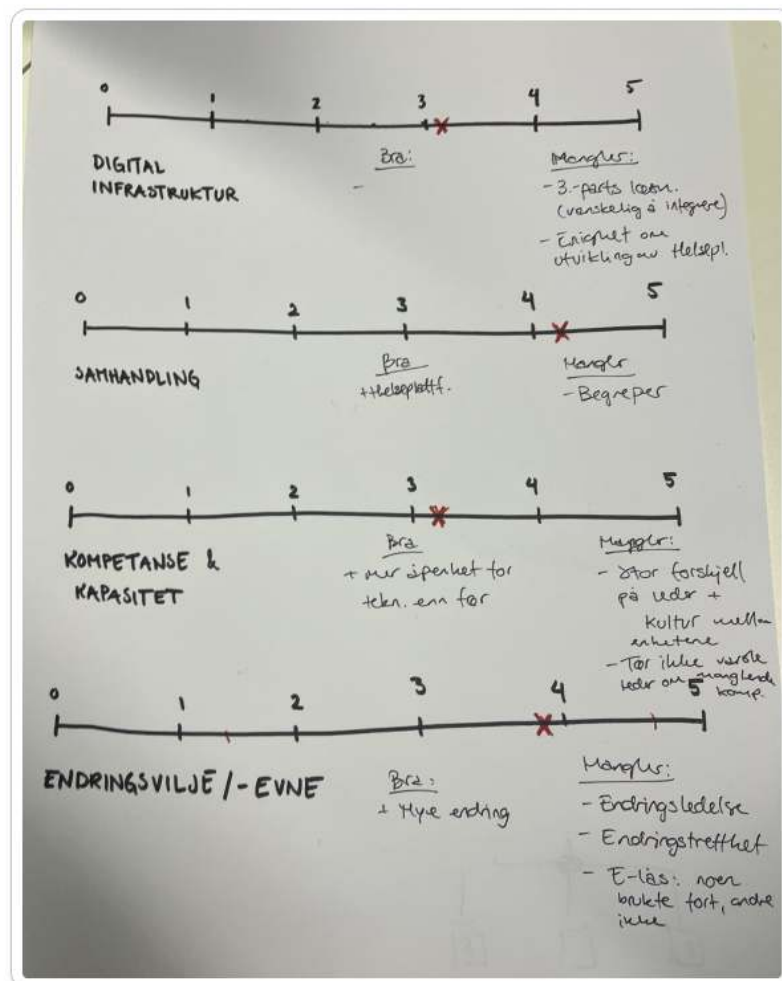


Figure 14: Rangeringsøvelse

F Intervju 6: Mammografibussen

Informant	Ansatt ved mammografibussen
Dato	1. mars 2026, 16:30–17:00
Format	Telefon, ustrukturert
Deltakere	1 gruppemedlem + 1 informant

Om mammografibussen

Mammografibussen er en del av Mammografiprogrammet, som inviterer kvinner mellom 50 og 69 år til undersøkelse hvert andre år. Kreftregisteret har overordnet ansvar for programmet og bussdriften, mens lokale sykehus og brystsentre samarbeider om den faglige gjennomføringen.

Ruteplan og geografisk dekning

Bussen besøker samme sted hvert andre år, der nordlige kommuner dekkes ett år og sørlige kommuner neste. Invitasjoner styres av kvinnens folkeregistrerte adresse og tilpasses bussens ruteplan, noe som sikrer forutsigbarhet i når kommuner og målgrupper får tilbud.

Drift og bemanning

Radiografer utfører undersøkelsene og jobber etter en turnus tilpasset bussens ruteplan. I perioder bussen er ute på oppdrag bor de ansatte på hotell. Driften er planlagt for å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet til kommunene langs ruten.

G Intervju 7: Hjemmesykepleien

Informant	Ansatt i hjemmesykepleien
Dato	14. mars 2026, 19:00-20:00
Format	Digitalt, ustrukturert
Deltakere	1 gruppedlem + 2 informanter

Arbeidsdag og oppgaver

En typisk arbeidsdag innebærer 16 til 20 besøk. Oppgavene spenner fra medisinaladministrering, matlaging og daglig stell til dusj, sårstell og kontroll av CVK og støttestrømper. De mest tidkrevende oppgavene er sårstell, dusj og daglig stell, delvis fordi hjemmemiljøet er lite ergonomisk tilrettelagt for helsepersonell.

Oppgavedeling og kompetansekrav

IV-behandling og håndtering av CVK må utføres av sykepleier på grunn av infeksjonsfare. Oppgaver som potensielt kan flyttes eller delegeres inkluderer antibiotika ved nøytropeni, smertepumpeoppfølging, IV-væske og ernæring samt enkelte palliative tiltak. Det foreslås at sykepleiere i større grad bør konsentrere seg om medisinske oppgaver, mens stell og praktiske gjøremål delegeres til helsefagarbeidere, studenter eller pensjonister. Motivasjon for avlastningspersonell vil primært være lønn og praktisk erfaring.

Kapasitet og prioritering

Hver sykepleier håndterer 2 til 4 pasienter med mer komplekse behov, noe som fører til prioritering og redusert oppfølgingstid per pasient. Mangel på sykepleiere er en reell utfordring, og hjemmesykehus vil øke presset på kommunen ytterligere.

Samarbeid mellom sykehus og kommune

Kommunikasjonen mellom sykehus og kommune beskrives som dårlig. Det er lite informasjon om pasienten tilgjengelig i helseopplysningen ved overføring, noe som gjør det krevende å sikre kontinuitet i oppfølgingen.

Hjemmesykehus: muligheter og utfordringer

Hjemmesykehus vurderes som positivt fordi det avlastar sykehuset. Samtidig pekes det på økt press på kommunen, mangel på sykepleiere og infeksjonsrisiko som sentrale utfordringer. Informanten foreslår et «minisykehus» eller mellomnivå mellom hjem og sykehus som kan redusere unødvendige innleggelser og gi et bedre tilbud til pasienter som ikke er syke nok for sykehus, men for syke til å være alene hjemme.

H Skriftlig kommunikasjon: Ambulansetjenesten

Informanter	To ambulansesarbeidere
Dato	Februar 2026
Format	Skriftlig kommunikasjon

Gruppen tok kontakt med to personer med erfaring fra ambulansetjenesten for å få innsikt i hvordan kapasitet og arbeidstid faktisk ser ut i praksis, med særlig fokus på distrikt. Spørsmålene dreide seg om dødtid på vakt, hva denne tiden brukes til, og om den kan utnyttes bedre i tilknytning til hjemmesykehus.

Dødtid og variasjon mellom stasjoner

Begge informantene understreker at dødtid varierer kraftig mellom stasjoner og vakttyper. I byene går man gjerne 8 til 12 timers vakter, og dødtid er sjeldent. På travle stasjoner kan man knapt rekke mat og toalettbesøk i løpet av en vakt. I distriktene er bildet annerledes. Her går man 48 til 72 timers vakter, oppdragene er færre, men tar gjerne 6 timer eller mer på grunn av store avstander. Stasjonene i distriktet er innredet som boliger med soverom, stue og kjøkken, og dødtiden fylles med hvile, matlaging, trening, faglesing og vedlikehold av bil og utstyr.

Beredskap og mentale krav

Begge informantene er tydelige på at dødtid ikke er «ledig» tid i vanlig forstand. Å koble av mellom oppdrag er en forutsetning for å prestere optimalt i akutte og potensielt livstruende situasjoner. Ambulansen skal stå klar til umiddelbar utrykning, og base-plasseringen er strategisk valgt for å sikre kortest mulig responstid. Norge har et mål om å nå alle potensielle pasienter innen 20 minutter, noe som forutsetter at mannskapet befinner seg på stasjonen. Det er også lovpålagte grenser for sammenhengende arbeidstid. Dersom dødtid brukes til oppgaver og en utrykning inntreffer, risikerer man å overskride disse grensene og dermed mangle en ressurs i distriktet i påfølgende timer.

Ambulansen og hjemmesykehus

Begge informantene ser muligheter, men peker på strukturelle begrensninger. Konseptet «community paramedicine» eller «mobile integrated healthcare» er allerede i bruk i land som Canada og Storbritannia, og er under utvikling i enkelte norske foretak. Helgeland prehospitale tjenester praktiserer allerede en form for dette, der pasienter med lavgradige tilstander kan bli hjemme etter undersøkelse og enkel behandling, alltid avklart med lege. Utfordringen med planlagte hjemmebesøk i en beredskapsbasert tjeneste er uforutsigbarhet. Ved trafikkulykke eller hjertestans omdirigeres ambulansen automatisk, noe som gjør det uforsvarlig å tildele ambulansen tidskritiske og planlagte oppgaver som medisinsadministrering. I distrikt kan økt oppdragsmengde bidra positivt til vedlikehold av medisinsk kompetanse, som ellers kan være lav på grunn av få oppdrag.

Mulig løsning

En informant foreslår å skille tydelig mellom beredskapsressurser og dedikerte hjemmesykehusenheter. Et eksempel kan være at ambulanspersonell roterer mellom vanlig ambulansvakt og egne hjemmesykehus-vakter, slik at kompetanse bygges i begge fagfelt uten at beredskapen svekkes. Ambulansetjenesten vurderes som best egnet til akutt og halvakkutt vurdering i hjemmet, og mindre egnet til planlagte og tidskritiske besøk som krever forutsigbarhet og kontinuitet.